AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

CARDIOLOGÍA

Sistema Cardiovascular

38 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Arritmias y Paro Cardiorrespiratorio

★★☆ 1.1. Lectura Sistemática del Electrocardiograma 4
★★☆ 1.2. Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático 5
★☆☆ 1.3. ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro 6
★★★ 1.4. Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo 7
★☆☆ 1.5. Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K 8
★★★ 1.6. Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White 9
★★★ 1.7. Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica 10
★★☆ 1.8. Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos GES 11
★☆☆ 1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo 12

02 Cardiopatía Coronaria

★★☆ 2.1. Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar GES 13
★★★ 2.2. Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía 14
★★★ 2.3. Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria 15
★★☆ 2.4. SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel GES 16
★★★ 2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES GES 17
★★★ 2.6. Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal GES 18

03 Insuficiencia Cardíaca y Enfermedades del Miocardio

★★★ 3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos 19
★★★ 3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos 20
★★☆ 3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón 21
★☆☆ 3.4. Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks 22
★★☆ 3.5. Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven 23
★★☆ 3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis 24

04 Valvulopatías, Cardiopatías Congénitas y Endocarditis

★☆☆ 4.1. Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas GES 26
★★★ 4.2. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular GES 27
★★☆ 4.3. Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica GES 28
★★☆ 4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática 29
★★☆ 4.5. Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral GES 31
★★★ 4.6. Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación GES 32
★★☆ 4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis 33

05 Hipertensión Arterial, Pericardio y Patología Vascular

★★★ 5.1. Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación GES 34
★★★ 5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES GES 35
★★☆ 5.3. Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla GES 36
★☆☆ 5.4. Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva GES 37
★★☆ 5.5. Pericarditis Aguda 38
★★☆ 5.6. Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis 39
★★★ 5.7. Disección Aórtica Aguda 40
★★☆ 5.8. Aneurisma de Aorta Abdominal 41
★★☆ 5.9. Tromboembolismo Pulmonar 42
★☆☆ 5.10. Trombosis Venosa Profunda 43

Índice · continuación

- Números que tienes que saber 44
- Fármacos de primera línea 47
- GES de la especialidad 49
- Plan de repaso de 7 días 51
- Índice por prioridad ★ 52

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

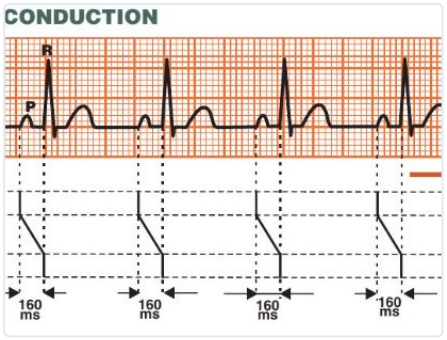
1.1 Lectura Sistemática del Electrocardiograma

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.01.4.007 Electrocardiograma — Realiza, interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden**: frecuencia, ritmo, eje, intervalos (PR, QRS, QT) y segmento ST-T-Q; el ECG se interpreta en **≤ 10 minutos**.
- **Papel a 25 mm/s**: **1 mm** = 0,04 s y **5 mm** = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares; en ritmos irregulares, QRS en 6 segundos × 10.
- **Ritmo sinusal**: P positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR, una P por cada QRS y R-R constante.
- **Eje normal**: DI y aVF positivos (−30° a +90°). PR > 200 ms = BAV de 1.er grado; PR < 120 ms con onda delta = preexcitación; QRS **≥ 120 ms** = bloqueo de rama o latido ventricular.
- QTc de Bazett normal < 440 ms (hombre) y < 460 ms (mujer); QTc > 500 ms = riesgo de torsión de puntas: suspender el fármaco y corregir K, Mg y Ca.



LATIDO NORMAL: P, QRS Y T
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 228

ALGORITMO · LECTURA SISTEMÁTICA DEL ECG: DEL TRAZADO A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

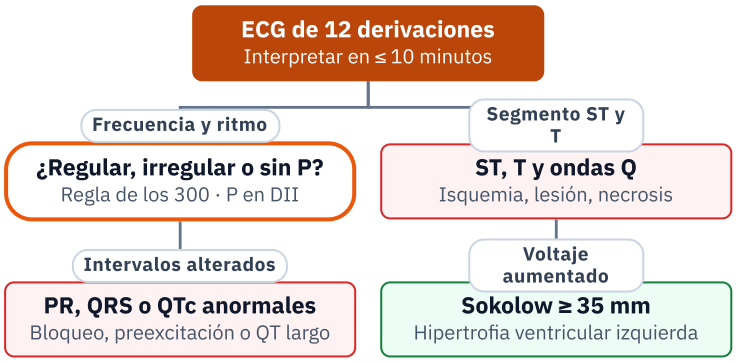


TABLA 1.1 · INTERVALOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS, VALORES NORMALES Y DIAGNÓSTICOS CLAVE EUNACOM

PARÁMETRO	VALOR NORMAL	ALTERACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA	SIGNIFICADO CLÍNICO / DIAGNÓSTICO EUNACOM
Frecuencia cardíaca	60 a 100 lpm	< 60 lpm / > 100 lpm	Bradicardia sinusal / taquicardia sinusal o arritmia
Onda P	< 120 ms y < 2,5 mm	P picuda en DII (> 2,5 mm) / P ancha y mellada en DI (> 120 ms)	Crecimiento auricular derecho (P pulmonar) / izquierdo (P mitrale)
Intervalo PR	120 a 200 ms (3 a 5 mm)	PR > 200 ms constante / PR < 120 ms con onda delta	Bloqueo AV de 1.er grado / síndrome de Wolff-Parkinson-White
Complejo QRS	< 120 ms (< 3 mm)	≥ 120 ms con R ancha en V6 / ≥ 120 ms con rsR' en V1	Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) / derecha (BCRD)
Intervalo QTc (Bazett)	< 440 ms (H) / < 460 ms (M)	QTc > 500 ms	Riesgo inminente de torsión de puntas (TV polimorfa)
Segmento ST	Isoeléctrico	Supradesnivel ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas	SCACEST (reperfusión urgente, Tema 2.5)
Eje del QRS	−30° a +90° (DI y aVF positivos)	DI+ aVF− y DII− / DI− aVF+	Desviación izquierda (HBAI, HVI) / derecha (TEP, EPOC, HBPI)
Voltaje (HVI)	S V1 + R V5/V6 < 35 mm	Sokolow ≥ 35 mm; Cornell > 28 mm (H) o > 20 mm (M)	Hipertrofia ventricular izquierda: hipertenso de alto riesgo

TRAMPAS EUNACOM

DATO	INTERPRETACIÓN	ERROR TÍPICO
P negativa en DII	Ritmo no sinusal (o electrodos invertidos)	Llamarlo sinusal por la frecuencia
PR 280 ms constante	BAV de primer grado	Indicar marcapaso
QTc 581 ms con claritromicina	Riesgo de torsión de puntas	Dar amiodarona

REGLA DE ORO **Frecuencia, ritmo, eje, intervalos, ST-T** — En diez minutos o menos

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.2 Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

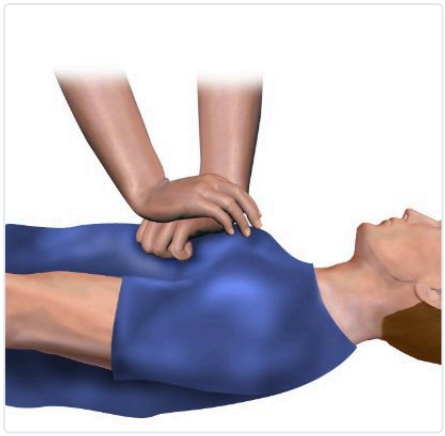
1.01.2.006
1.05.2.012
4.01.2.030
Paro cardiorespiratorio

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

También: Resucitación cardiorespiratoria

LO QUE TE PREGUNTAN

- PCR = inconsciencia + sin respiración (o gasping) + sin pulso carotídeo en **≤ 10 segundos**; ante la duda, comprimir.
- **Primer gesto**: pedir ayuda (131 / Código Azul) e iniciar compresiones (C-A-B); no intubar, canalizar ni dar adrenalina antes; el golpe precordial no se hace.
- **Compresiones**: 100-120 por minuto, **≥ 5 cm** (máx. **6 cm**), permitir la re-expansión, interrupciones < 10 s, relevo cada **2 minutos**.
- **Relación 30**:2 sin vía aérea avanzada; con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 segundos (sin hiperventilar).
- DEA: parches infraclavicular derecho y axilar izquierdo; nadie toca al paciente al analizar o descargar; tras la descarga, RCP de inmediato por **2 minutos** sin chequear pulso.



MANOS SOBRE EL ESTERNÓN
Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0

ALGORITMO · PARO CARDIORRESPIRATORIO: DEL COLAPSO AL DESFIBRILADOR

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

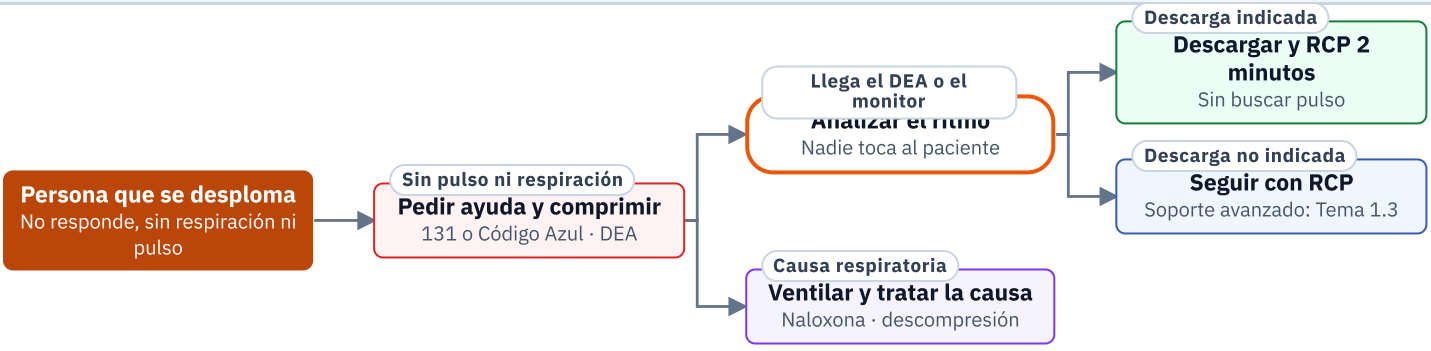


TABLA 1.2 · RCP DE ALTA CALIDAD: PARÁMETROS POR GRUPO DE EDAD

PARÁMETRO	ADULTO	NIÑO	LACTANTE
Frecuencia de compresión	100-120 por minuto	100-120 por minuto	100-120 por minuto
Profundidad	≥ 5 cm (máx. 6 cm)	≥ 1/3 del tórax (≈ 5 cm)	≥ 1/3 del tórax (≈ 4 cm)
Relación compresión:ventilación	30:2 (1 ventilación cada 6 s con vía aérea avanzada)	30:2 un reanimador; 15:2 dos reanimadores	30:2 un reanimador; 15:2 dos reanimadores
Técnica	Talón de ambas manos, mitad inferior del esternón	Una o dos manos	Dos dedos o pulgares con manos rodeando el tórax
Ritmo del paro más frecuente	FV / TV sin pulso (cardíaco)	Asistolia / AESP (respiratorio)	Asistolia / AESP (respiratorio)
Interrupciones y relevo	< 10 s; relevo cada 2 min	< 10 s; relevo cada 2 min	< 10 s; relevo cada 2 min

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Sin conciencia, sin respiración ni pulso	Pedir ayuda y comprimir	Intubar o pedir un ECG primero
Paro presenciado, sin desfibrilador a mano	Comprimir hasta que llegue	Esperar el desfibrilador sin comprimir
Paciente intubado en RCP	Compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s	Seguir con 30 a 2 e hiperventilar

REGLA DE ORO **Sin conciencia, sin respiración, sin pulso: paro** — Pulso ≤ 10 segundos

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **3–5, 80–81** (págs. 8, 17–18) · solucionario págs. 20, 30.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.3 ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.01.5.004 Desfibrilación — Realizar

También: Paro cardiorespiratorio · Resucitación cardiorespiratoria

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ritmos desfibrilables**: FV y TV sin pulso (descarga de 200 J bifásicos y RCP por **2 minutos**). No desfibrilables: asistolia y AESP (RCP, adrenalina y causas reversibles).
- Inmediatamente después de la descarga se reanudan las compresiones por **2 minutos**, sin palpar pulso ni mirar el monitor.
- **Adrenalina 1 mg EV cada 3-5 minutos**: tras la 2.ª descarga en FV/TVsp, pero lo antes posible en asistolia/AESP.
- Amiodarona **300 mg** EV tras la 3.ª descarga en FV/TVsp refractaria (luego **150 mg**); alternativa: lidocaína **1-1,5 mg/kg**.
- La descarga en asistolia está contraindicada. La desfibrilación (paro, sin pulso) no es la cardioversión (con pulso, sincronizada).



FIBRILACIÓN VENTRICULAR
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 307

ALGORITMO · PARO CARDIORRESPIRATORIO AVANZADO: DEL MONITOR AL RETORNO DE CIRCULACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

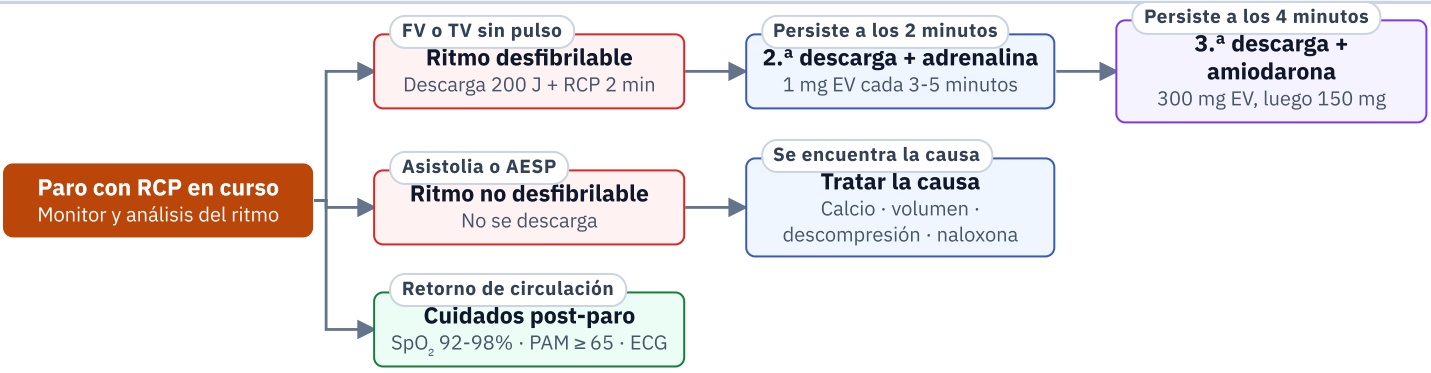


TABLA 1.3 · RESUMEN COMPARATIVO DE FÁRMACOS Y MANEJO EN EL PARO CARDIORRESPIRATORIO DEL ADULTO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR EN ADULTOS	MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN	INDICACIÓN / VÍA ACLS
Desfibrilación eléctrica	200 J bifásico (360 J monofásico)	Minuto 0, 2 y 4 si persiste el ritmo	Exclusivo de FV y TV sin pulso
Adrenalina (epinefrina)	1 mg EV en bolo cada 3-5 min	Tras la 2.ª descarga en FV/TVsp; lo antes posible en asistolia/AESP	Todos los ritmos del paro
Amiodarona	300 mg EV en bolo (2.ª dosis 150 mg)	Tras la 3.ª descarga fallida	FV/TVsp refractarias
Lidocaína (alternativa)	1 a 1,5 mg/kg EV	Si no hay amiodarona	FV/TVsp refractarias
Gluconato de calcio 10%	10 a 20 mL EV en 2-5 min	Sospecha de hiperkalemia, hipocalcemia o toxicidad por bloqueadores del calcio	Asistolia/AESP con QRS ancho o paciente en diálisis
Sulfato de magnesio	2 g EV	Torsión de puntas o hipomagnesemia	FV/TV polimorfa con QT largo
Bicarbonato de sodio	50 mEq EV	Solo hiperkalemia grave, tricíclicos o acidosis previa	No es de rutina

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Asistolia en dos derivaciones	RCP + adrenalina + causas	Descargar 200 J
Recién descargado, FV persiste	Reanudar RCP por 2 minutos	Palpar el pulso o mirar el monitor
FV persiste tras la 3.ª descarga	Amiodarona 300 mg EV	Dar amiodarona antes de la tercera

REGLA DE ORO **FV / TV sin pulso: descarga 200 J y RCP 2 min** — Adrenalina tras la 2.ª · amiodarona tras la 3.ª

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.4 Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.012 Fibrilación auricular crónica — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Fibrilación auricular paroxística · Flutter auricular

LO QUE TE PREGUNTAN

- FA: pulso irregularmente irregular, ECG sin ondas P, línea de base ondulante (ondas f) y R-R irregular; causa de 1 de cada 3 ACV isquémicos.
- **FA inestable (shock, edema pulmonar, isquemia)**: cardioversión eléctrica sincronizada inmediata; no confundir con desfibrilación.
- **Paciente estable**: anticoagular y controlar la frecuencia (meta FC < **110 lpm**); metoprolol o verapamilo/diltiazem; con FEVI reducida, betabloqueador o digoxina y NO verapamilo.
- Betabloqueadores no se usan en el asma ni en el EPOC con broncoespasmo (atenolol, carvedilol); se prefiere el calcioantagonista.
- **FA < 48 h**: se puede cardiovertir; FA > **48 h** o dudosa: **3 semanas** de anticoagulación o ETE antes, y **≥ 4 semanas** de anticoagulación después.

ALGORITMO · FIBRILACIÓN AURICULAR: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

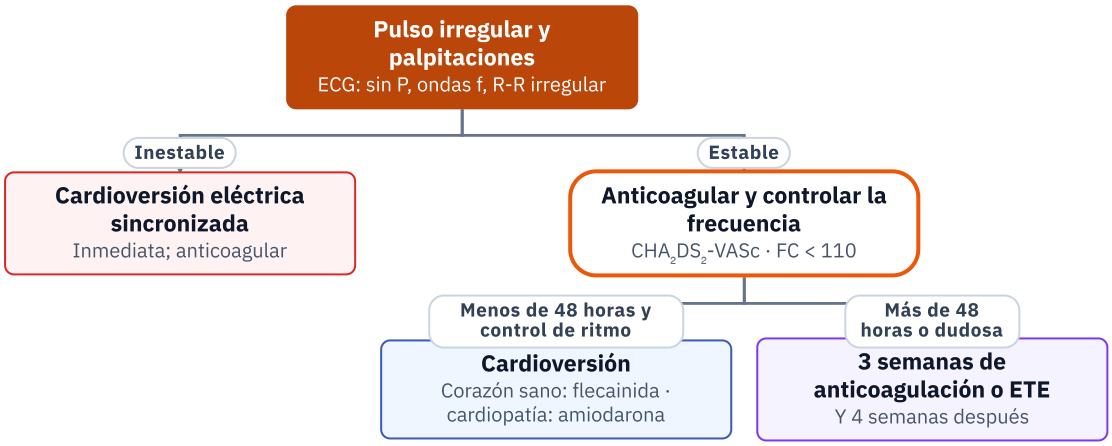


TABLA 1.4 · FÁRMACOS PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y DE RITMO EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

FÁRMACO / GRUPO	MECANISMO / DOSIS	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN / ADVERTENCIA CRÍTICA
Metoprolol / bisoprolol / carvedilol	Betabloqueadores (VO; metoprolol EV 5 mg lento)	Control de frecuencia de 1.ª línea (incluso en IC compensada)	Asma y EPOC con broncoespasmo, bloqueo AV avanzado, shock
Verapamilo / diltiazem	Calcioantagonistas no DHP	Control de frecuencia sin insuficiencia cardíaca	CONTRAINDICADOS en IC con FEVI reducida e hipotensión
Digoxina	Inhibe la bomba Na/K; frena el nodo AV	Control de frecuencia en IC o en sedentarios	Insuficiencia renal, hipokalemia; preexcitación
Flecainida / propafenona	Antiarrítmico clase Ic (VO)	Cardioversión farmacológica en corazón SANO (< 48 h)	ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADAS en infarto previo o IC (CAST)
Amiodarona	Antiarrítmico clase III (EV / VO)	Cardioversión en cardiopatía estructural o IC; control de frecuencia en el crítico	Toxicidad pulmonar, tiroidea, hepática y corneal; riesgo embólico si no se anticoagula
Cardioversión eléctrica	Choque sincronizado bajo sedación	FA inestable (inmediata) o de reciente inicio	FA > 48 h: 3 semanas de anticoagulación o ETE antes

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
FA con PA 85/40 y extremidades frías	Cardioversión eléctrica	Verapamilo o amiodarona
FA > 48 h, estable	Anticoagular 3 semanas o ETE; frenar	Cardiovertir de inmediato
FA + EPOC o asma	Calcioantagonista no DHP	Atenolol o carvedilol

REGLA DE ORO **Pulso irregular + ECG sin P** — Causa de 1 de cada 3 ACV

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **6–10, 71–72** (págs. 8–9, 16) · solucionario págs. 20–21, 29.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.5 Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.01.3.003 **Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante** — Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- La FA se anticoagula según el riesgo embólico (CHA_2DS_2-VASc), no según los síntomas, la frecuencia ni el ritmo.
- **CHA_2DS_2-VASc**: IC 1, HTA 1, edad **≥ 75** = 2, DM 1, ACV/AIT = 2, enfermedad vascular 1, edad 65-74 = 1, sexo femenino 1.
- Anticoagulación obligatoria con **≥ 2 puntos** en el hombre y **≥ 3 en** la mujer; considerar con 1 y 2, respectivamente; con 0 y 1 no se anticoagula.
- **Primera línea en la FA no valvular**: ACOD (apixabán **5 mg** c/**12 h**, rivaroxabán **20 mg**/día, dabigatrán **150 mg** c/**12 h**); la edad avanzada no contraindica.
- **Estenosis mitral reumática moderada-grave y prótesis mecánica**: antagonista de vitamina K (acenocumarol o warfarina; INR 2-3 y 2,5-3,5 en prótesis mecánica mitral); ACOD contraindicados.
- La aspirina (sola o con clopidogrel) no previene el ACV en la FA y sangra: es la respuesta incorrecta clásica.

ALGORITMO · FIBRILACIÓN AURICULAR: A QUIÉN SE ANTICOAGULA Y CON QUÉ

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

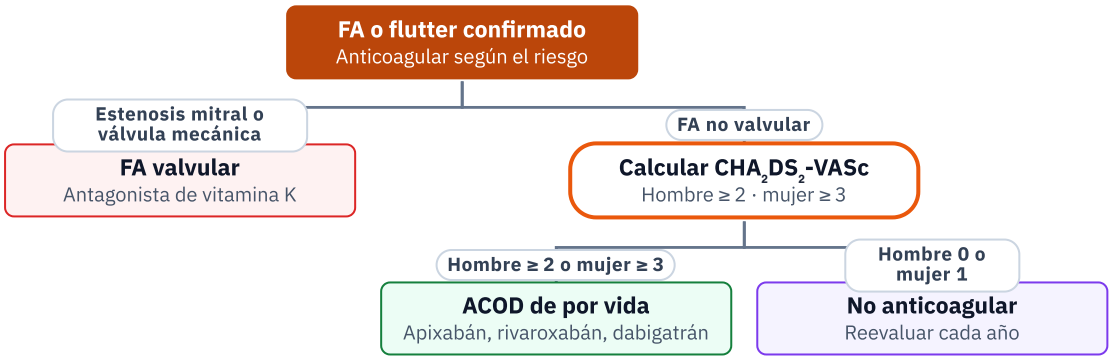


TABLA 1.5 · ANTICOAGULANTES ORALES EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

FÁRMACO / GRUPO	MECANISMO / DOSIS	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN / ADVERTENCIA CRÍTICA
Apixabán (ACOD)	Inhibidor del factor Xa; 5 mg cada 12 h (2,5 mg si 2 de: ≥ 80 años, ≤ 60 kg, creatinina ≥ 1,5)	Anticoagulación de 1.ª línea en FA no valvular; el adulto mayor y la IRC	Estenosis mitral reumática o válvula mecánica
Rivaroxabán (ACOD)	Inhibidor del factor Xa; 20 mg al día con la comida (15 mg si CrCl 15-50)	FA no valvular	Estenosis mitral reumática o válvula mecánica; tomar con alimento
Dabigatrán (ACOD)	Inhibidor de la trombina; 150 mg cada 12 h	FA no valvular con función renal conservada	80% de eliminación renal; antídoto idarucizumab
Acenocumarol / warfarina	Antagonistas de vitamina K; INR 2,0-3,0 (2,5-3,5 prótesis mecánica mitral)	FA valvular (estenosis mitral reumática) y prótesis mecánicas	Requieren controles del INR y ajuste de la dieta; muchas interacciones
Aspirina (± clopidogrel)	Antiagregante	NO sirve para prevenir ACV en la FA	Contraindicada como monoterapia en FA: no reduce el ACV y sangra

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Mujer 76 años, HTA y DM, FA asintomática	ACOD permanente (puntaje 5)	Aspirina o no tratar
Mujer 78 años, puntaje 4	Anticoagular	No hacerlo por la edad
Hombre, puntaje 0	No anticoagular	Dar anticoagulante por los síntomas

REGLA DE ORO **CHA_2DS_2-VASc: hombre ≥ 2 · mujer ≥ 3** — No depende de los síntomas

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 1.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

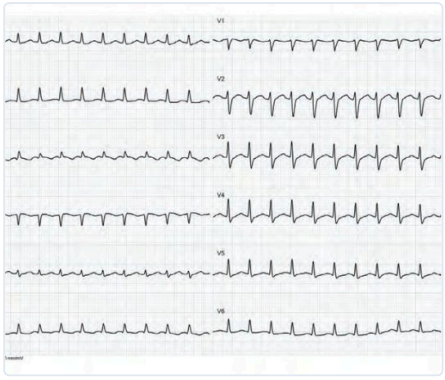
1.6 Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **TPSV**: taquicardia regular de QRS estrecho, **150-220 lpm**, de inicio y fin súbitos; **60%** reentrada nodal, **30%** por vía accesoria (WPW).
- **Estable**: 1.º maniobras vagales (Valsalva modificado), 2.º adenosina **6 mg** EV en bolo ultrarrápido + **20 mL** de suero (luego **12 mg**), 3.º verapamilo **5-10 mg** EV lento.
- **Inestable**: cardioversión eléctrica sincronizada inmediata. La presión ocular está contraindicada y el masaje carotídeo no se recomienda en el adulto mayor ni en niños.
- **Adenosina**: vida media < 10 s (por eso bolo rápido y suero); contraindicada en el asma grave; da rubor, opresión torácica y pausa transitoria.
- **WPW en ritmo sinusal**: PR < 120 ms + onda delta + QRS ancho.



TPSV POR REENTRADA NODAL
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 270

ALGORITMO · TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR: DE LA CRISIS A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

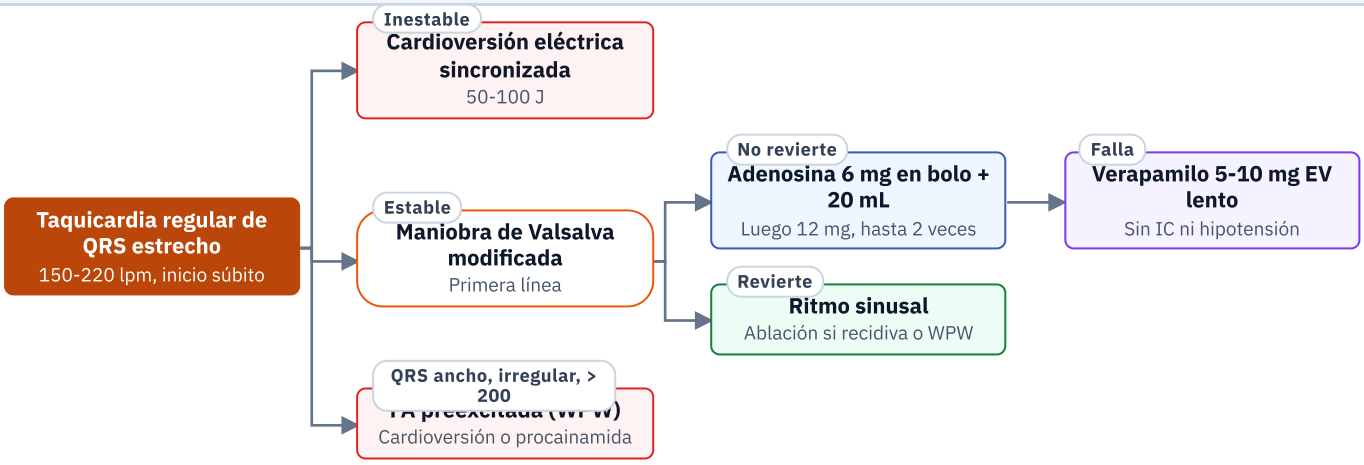


TABLA 1.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS EN TAQUICARDIAS DE URGENCIA

TIPO DE TAQUICARDIA	RITMO / COMPLEJO QRS	MANEJO DE 1.ª ELECCIÓN (ESTABLE)	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS
TPSV por reentrada nodal	Regular / QRS estrecho (< 120 ms), 150-220 lpm	Valsalva modificado → adenosina 6 mg EV (luego 12 mg)	Adenosina en asma grave; verapamilo en IC o hipotensión
TRAV ortodrómica (WPW)	Regular / QRS estrecho	Valsalva → adenosina; ablación	Evitar digoxina
FA con WPW (preexcitada)	IRREGULAR / QRS ancho (> 120 ms), > 200 lpm	Cardioversión eléctrica / procainamida	Adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina, betabloqueadores y amiodarona
Flutter auricular 2:1	Regular, 150 lpm / QRS estrecho	Betabloqueador o diltiazem; ablación del istmo	Cardioversión sin descartar trombo si > 48 h
Taquicardia ventricular	Regular / QRS ancho	Amiodarona o cardioversión (Tema 1.7)	Verapamilo (colapso hemodinámico)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Taquicardia regular angosta, estable	Valsalva modificado → adenosina 6 mg	Amiodarona o verapamilo primero
Adenosina que no revierte	Bolo rápido con 20 mL de suero; 12 mg	Pasarla lenta
Inestable	Cardioversión sincronizada	Insistir con fármacos

REGLA DE ORO **Inestable: cardioversión** — Estable: Valsalva → adenosina → verapamilo

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **11–13, 87–88** (págs. 9, 18) · solucionario págs. 21, 31.

Clase 1.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.7 Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica

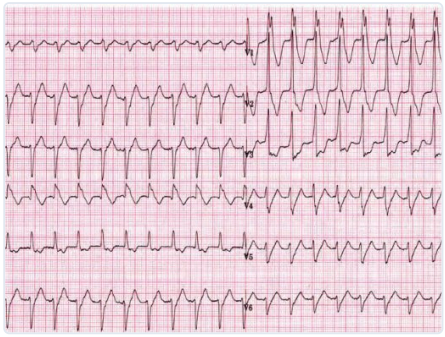
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.009 Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cardioversión eléctrica

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Taquicardia regular de QRS ancho (≥ 120 ms)** = TV hasta demostrar lo contrario, sobre todo con infarto previo o cardiopatía estructural.
- **Primero pulso y estabilidad**: sin pulso es paro (desfibrilación); con pulso e inestable, cardioversión eléctrica sincronizada inmediata, cualquiera sea la taquiarritmia.
- **TV estable**: amiodarona **150 mg** EV en **10 minutos**; el verapamilo y el diltiazem están contraindicados (colapso hemodinámico).
- **Cardioversión** = descarga sincronizada con pulso; desfibrilación = descarga no sincronizada en el paro (FV/TV sin pulso) y en la TV polimorfa.
- **Favorecen TV**: disociación AV, latidos de captura o fusión, QRS > 140-160 ms, concordancia precordial y eje extremo.



TV CON PATRÓN DE BCRD
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 283

ALGORITMO · TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO: DEL PULSO A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

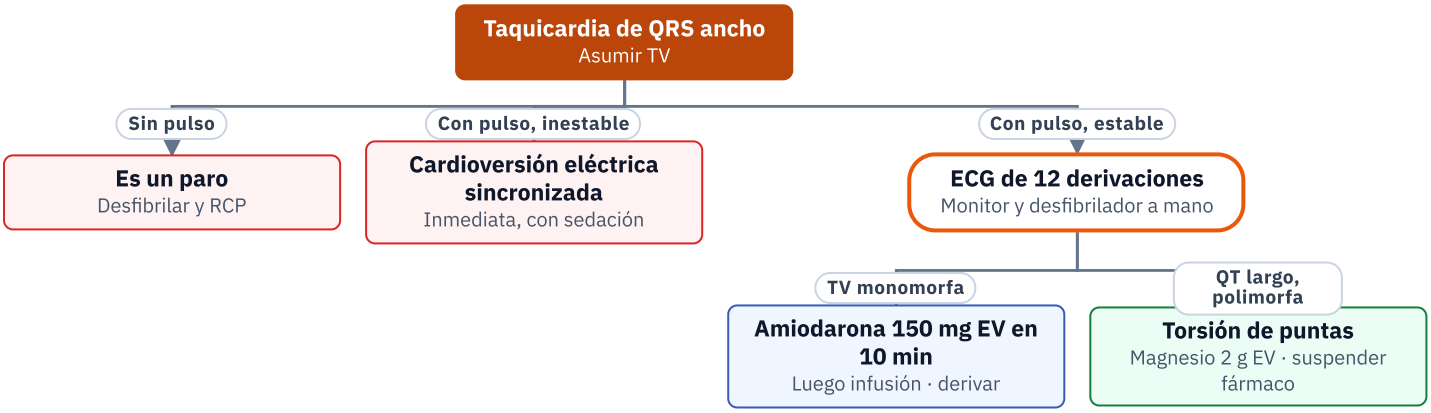


TABLA 1.7 · TAQUICARDIAS DE COMPLEJO ANCHO: RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE URGENCIA

TIPO DE TAQUICARDIA	RITMO / COMPLEJO QRS	MANEJO DE 1.ª ELECCIÓN	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS
TV monomorfa estable	Regular / QRS ancho (> 120 ms)	Amiodarona 150 mg EV en 10 min (o cardioversión)	Verapamilo y diltiazem (colapso hemodinámico)
TV (o FA, TPSV) inestable	Cualquier taquiarritmia con compromiso hemodinámico	Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata	Retrasar con fármacos o estudios
TV sin pulso / FV	Sin pulso (paro)	Desfibrilación 200 J + RCP (Tema 1.3)	Cardioversión sincronizada
Torsión de puntas (QT largo)	Polimorfa; QTc > 500 ms	Sulfato de magnesio 2 g EV; suspender fármaco; corregir K, Mg	Amiodarona, procainamida, sotalol
FA preexcitada (WPW)	Irregular / QRS ancho, > 200 lpm	Cardioversión sincronizada o procainamida (Tema 1.6)	Adenosina, verapamilo, digoxina, betabloqueadores
TPSV con aberrancia	Regular / QRS ancho	Se trata como TV si hay duda	Verapamilo si no se aclara el origen

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Taquiarritmia con PA 70/40 y confusión	Cardioversión sincronizada	Maniobras vagales o adenosina
Infarto previo + síncope con reanimación	Pensar en TV	Pensar en TPSV o FA
QTc 581 ms con claritromicina	Suspender el fármaco y corregir K y Mg	Dar amiodarona

REGLA DE ORO **Ancho = TV hasta demostrar lo contrario** — Infarto previo: TV

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 22.

Clase 1.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.8 Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos

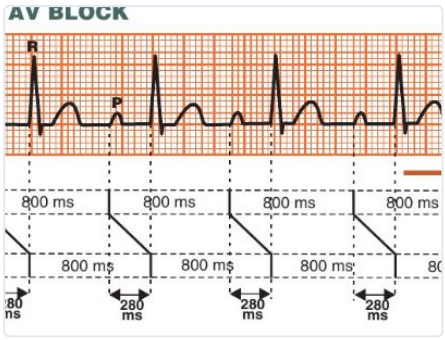
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

LO QUE TE PREGUNTAN

- **BAV 1.er grado**: PR > 200 ms constante, benigno, sin marcapaso. Mobitz I (Wenckebach): PR progresivo y pausa, nodal, se observa.
- Mobitz II (PR constante y P bloqueadas) y BAV completo (disociación AV con escape lento): infranodales, indicación de marcapaso definitivo.
- La disociación AV (P y QRS independientes) con FC cercana a **30-40 lpm** es el sello del BAV completo; síncope súbito con bradicardia severa = Stokes-Adams.
- **Bradicardia inestable**: atropina **1 mg** EV cada **3-5 min** (máx. **3 mg**) → marcapaso transcutáneo → adrenalina o dopamina → marcapaso transvenoso.
- La atropina sirve en el bloqueo nodal (Mobitz I, infarto inferior) pero poco en el infranodal (Mobitz II y BAV completo con QRS ancho).



BAV DE 1.ER GRADO: PR 280 MS
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 228

ALGORITMO · BRADICARDIA Y BLOQUEOS AV: DEL ECG AL MARCAPASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

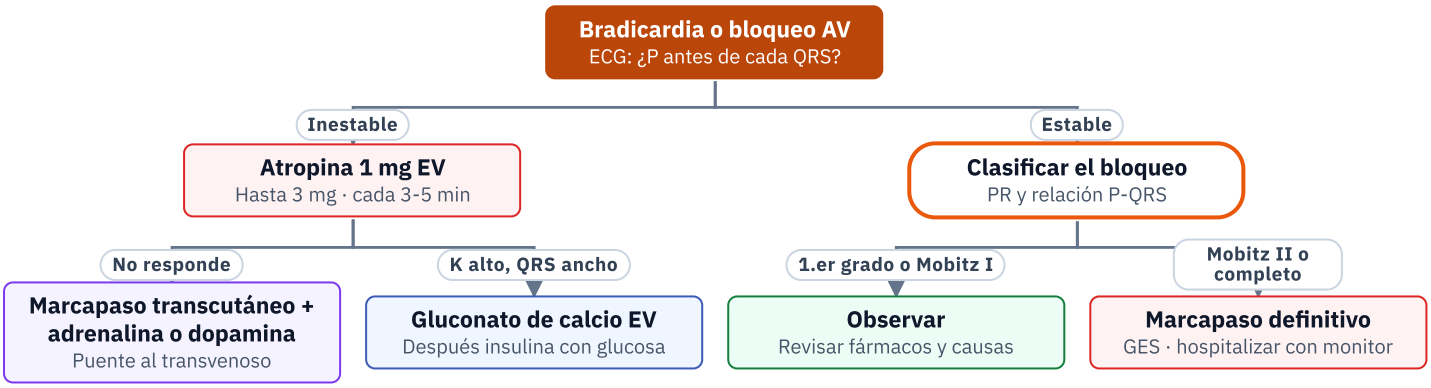


TABLA 1.8 · CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUEOS AV: HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y CONDUCTA

TIPO DE BLOQUEO AV	PATRÓN EN EL ECG	NIVEL ANATÓMICO DE LA LESIÓN	CONDUCTA / TRATAMIENTO DEFINITIVO
BAV 1.er grado	PR > 200 ms constante, todas las P conducen	Nodo AV (suprahisiano)	No requiere marcapaso (control médico, revisar fármacos)
BAV 2.º grado Mobitz I (Wenckebach)	PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce	Nodo AV (suprahisiano)	Observación; marcapaso solo si hay síntomas graves
BAV 2.º grado Mobitz II	PR constante con ondas P bloqueadas súbitas	His-Purkinje (infranodal)	MARCAPASO DEFINITIVO
BAV 3.er grado (completo)	Disociación AV total (P y QRS independientes), escape lento	Infranodal / His-Purkinje (o nodal)	MARCAPASO DEFINITIVO
Enfermedad del nodo sinusal / taqui-bradi	Bradicardia sinusal severa, pausas, alternancia con FA	Nodo sinusal	Marcapaso definitivo + fármacos frenadores
Bradicardia inestable	FC < 50 con hipotensión, shock o isquemia	Cualquiera	Atropina 1 mg → marcapaso transcutáneo → adrenalina o dopamina
Bradicardia con hiperkalemia	QRS ancho, T picudas, K > 7	Metabólico	Gluconato de calcio EV primero

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
PR 280 ms constante	BAV de 1.er grado: observar	Implantar marcapaso
PR constante y P bloqueada súbita	Mobitz II: marcapaso definitivo	Observación ambulatoria
Atropina sin respuesta, shock	Marcapaso transcutáneo + adrenalina	Repetir atropina hasta 6 mg o amiodarona

REGLA DE ORO **1.er grado: PR largo · Mobitz I: PR progresivo** — Benignos, nodales

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **15–17, 55–56** (págs. 9–10, 14) · solucionario págs. 22, 27.

Clase 1.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

1.9 Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo

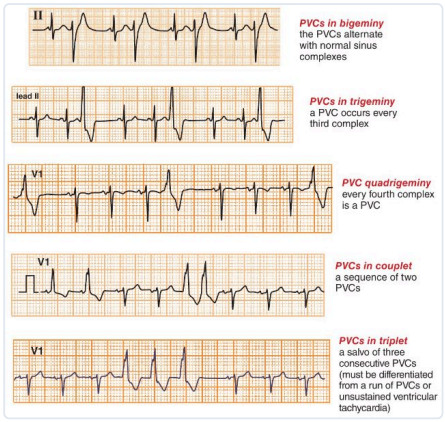
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.01.1.011 Extrasistolía ventricular benigna — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

También: Holter de ritmo

LO QUE TE PREGUNTAN

- EV: QRS ancho prematuro, sin onda P y con pausa compensadora completa.
- **Benignas**: corazón sano, aisladas, monomorfas, desaparecen con el ejercicio y carga < **10%** en el Holter.
- **Banderas rojas**: cardiopatía estructural, síncope, antecedente familiar de muerte súbita, polimorfas, parejas o TVNS, aumentan con el ejercicio.
- **Tratamiento**: tranquilizar, suprimir gatillantes; betabloqueador o verapamilo si molestan; no antiarrítmicos clase I.
- **Carga de EV > 10 a 15% puede causar miocardiopatía**: ecocardiograma y derivar para ablación.
- **Holter 24 h**: palpitaciones, presíncope o síncope, cuantificar EV, FA paroxística y pausas; informe: FC, pausas, carga, TVNS, correlación con síntomas.



EV EN BIGEMINISMO Y PAREJAS
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 221

ALGORITMO · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES: DEL SÍNTOMA AL HOLTER Y LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

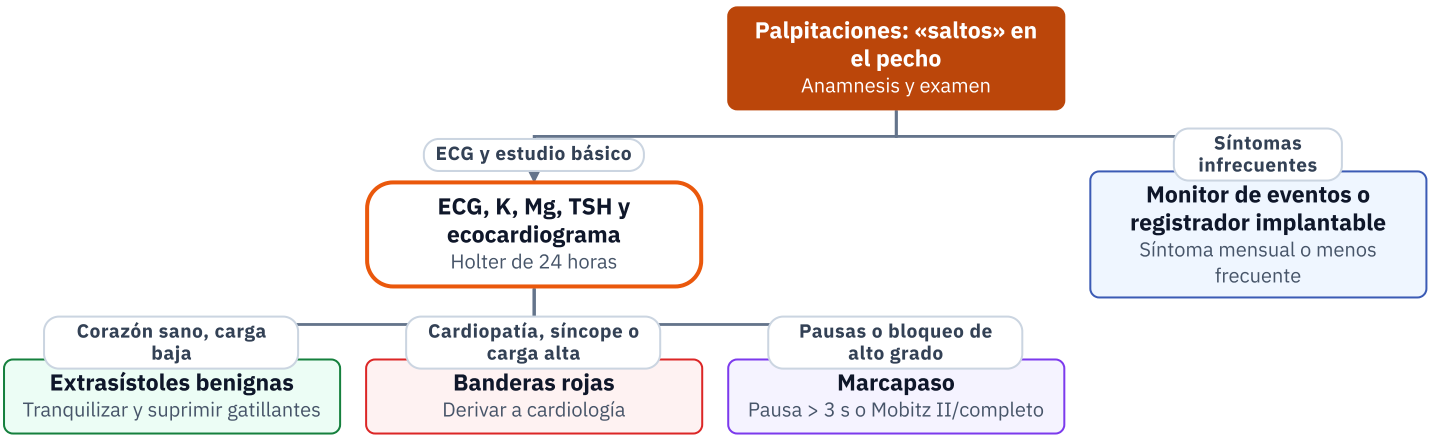


TABLA 1.9 · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES: BENIGNAS VS SIGNOS DE ALARMA

CARACTERÍSTICA	BENIGNA	ALARMA (DERIVAR)
Corazón	Estructuralmente sano; ECG y ecocardiograma normales	Infarto previo, miocardiopatía, FEVI deprimida
Morfología y patrón	Aislada y monomorfa	Polimorfa, parejas, TV no sostenida, R sobre T
Con el ejercicio	Desaparece o disminuye	Aumenta
Síntomas y antecedentes	Palpitaciones aisladas	Síncope o historia familiar de muerte súbita
Carga en el Holter	Menos de 10%	Más de 10 a 15%: riesgo de miocardiopatía por EV
Conducta	Tranquilizar y suprimir gatillantes; betabloqueador si molestan	Estudio y derivación; evitar antiarrítmicos clase I

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Carga 22% + FEVI 40%	Ecocardiograma y derivar para ablación	Tranquilizar y repetir en 5 años
Infarto previo, FEVI 35%, EV frecuentes	Betabloqueador y tratar la IC	Flecainida (CAST)
FA + atenolol y verapamilo, episodios breves de malestar	Holter de 24 horas (taqui-bradi)	Tilt test o ecocardiograma

REGLA DE ORO **QRS ancho prematuro, sin P, pausa completa** — Corazón sano, aisladas, monomorfas, carga < 10%

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **70** (pág. 16) · solucionario pág. 29.

Clase 1.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

2.1 Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar

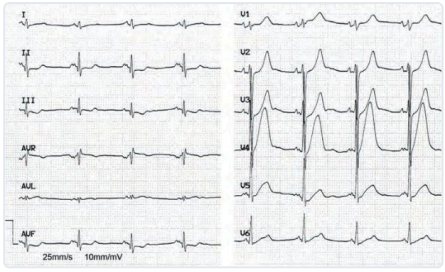
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.01.4.007 Electrocardiograma — Realiza, interpreta y emplea

También: Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Todo dolor torácico agudo**: ECG de 12 derivaciones en **≤ 10 minutos**, monitor, PA en ambos brazos y troponina; el SCACEST se reperfunde sin esperar la troponina.
- **Un ECG normal no descarta un SCA**: se repite cada **15-30 min** y se agregan V7-V9 y V3R-V4R según el caso.
- La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/**1 h**); una sola troponina normal no descarta angina inestable, y una elevación estable sin curva sugiere daño crónico.
- **Letales**: SCA, disección aórtica, embolia pulmonar, neumotórax a tensión y rotura esofágica; el taponamiento completa la lista.



T HIPERAGUDAS V2-V4
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 165

ALGORITMO · DOLOR TORÁCICO AGUDO: DEL PRIMER CONTACTO AL DIAGNÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

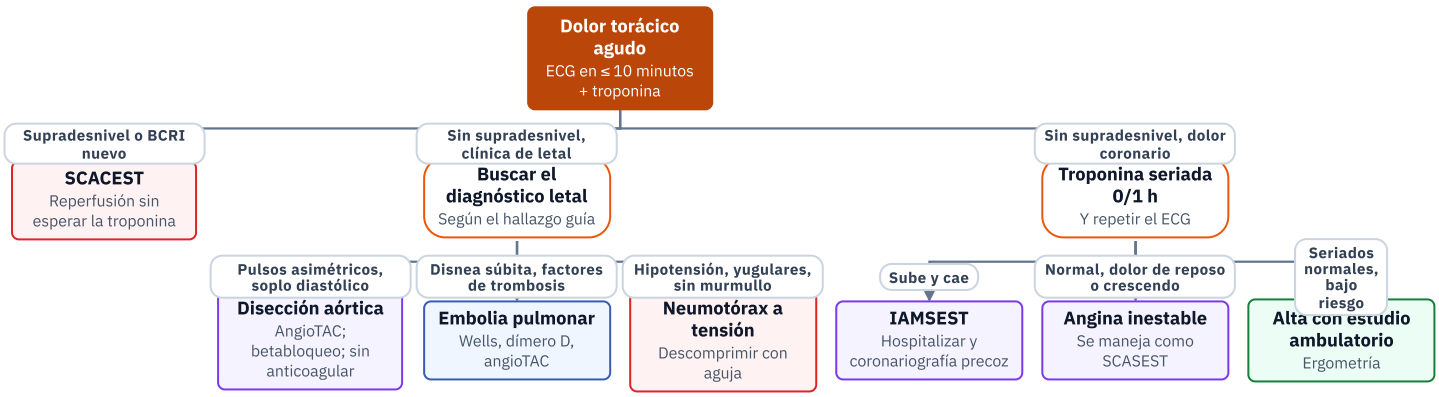


TABLA 2.1 · TABLA 2.1.A · DIAGNÓSTICOS LETALES DEL DOLOR TORÁCICO: CLAVE CLÍNICA, EXAMEN DE ELECCIÓN Y CONDUCTA INICIAL

DIAGNÓSTICO	CLAVE CLÍNICA	EXAMEN DE ELECCIÓN	CONDUCTA INICIAL
SCA (infarto, angina inestable)	Opresivo > 20 min, irradiado, diaforesis; factores de riesgo	ECG ≤ 10 min + troponina seriada	SDST → reperfusión; SCASEST → Tema 2.4
Disección aórtica	Desgarrante, a la espalda; pulsos o PA asimétricos; soplo diastólico	AngioTAC de aorta (ETE si inestable)	Betabloqueo EV, PAS 100-120; tipo A: cirugía; nunca fibrinolizar
Embolia pulmonar	Disnea y dolor pleurítico súbitos, taquicardia, factores de trombosis	Wells + dímero D; angioTAC de arterias pulmonares	Anticoagulación (empírica si probabilidad alta)

REGLA DE ORO **ECG ≤ 10 min; monitor; PA en ambos brazos** — No se espera la troponina para reperfundir

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

2.2 Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.001 Angina crónica estable — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Test de esfuerzo · Cintigrafía de perfusión miocárdica · Coronariografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Angina típica** = dolor opresivo retroesternal + gatillado por esfuerzo o estrés + cede con reposo o nitroglicerina en < **5 min** (los 3 criterios de Diamond-Forrester); 2 criterios = atípica.
- **Gravedad CCS**: I solo esfuerzos extenuantes; II más de 2 cuadras o un piso; III 1-2 cuadras o un tramo de escalera; IV angina con cualquier actividad o en reposo.
- La ergometría (Bruce) es la primera prueba si puede ejercitarse y el ECG basal es interpretable; positiva con infradesnivel horizontal o descendente del ST **≥ 1 mm** a 80 ms del punto J.
- **Alto riesgo en ergometría**: ST **≥ 2 mm** o en **≥ 5 derivaciones**, precoz (< 5 METs), caída de la PAS > **10 mmHg** o TV: coronariografía.
- Con BCRI, marcapaso, preexcitación, HVI con sobrecarga o digoxina, o si no puede ejercitarse: ecocardiograma con dobutamina o cintigrafía de perfusión (SPECT).

ALGORITMO · ANGINA CRÓNICA ESTABLE: DEL SÍNTOMA A LA CORONARIOGRAFÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

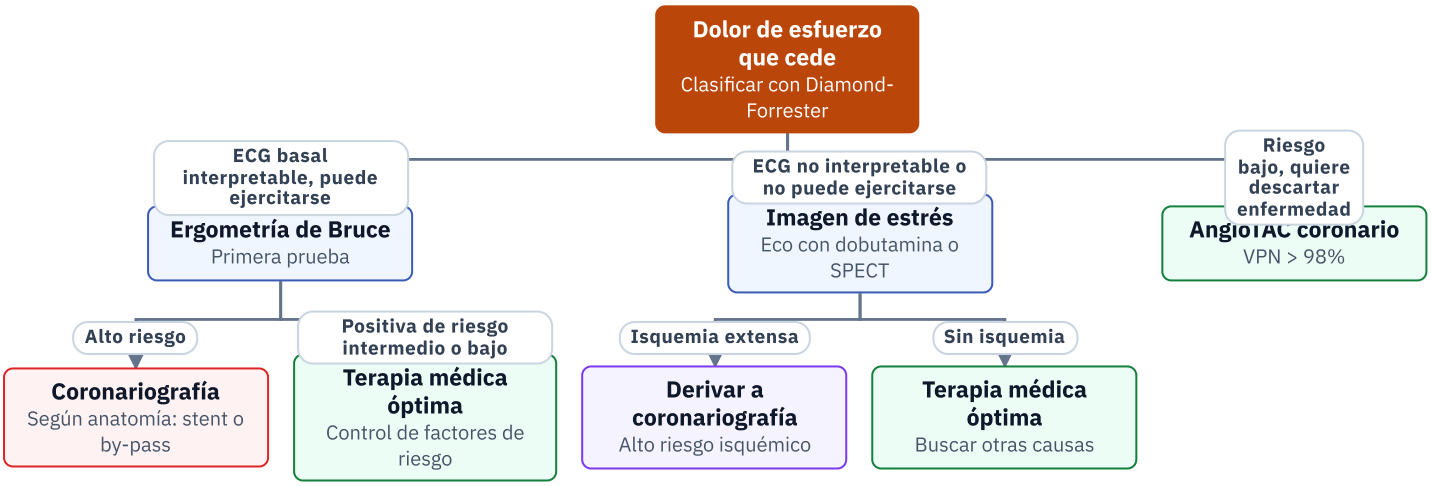


TABLA 2.2 · TABLA 2.2.A · PRUEBAS PARA EL ESTUDIO DE LA ANGINA ESTABLE: CUÁNDO USARLAS Y QUÉ INFORMAN

PRUEBA	CUÁNDO SE INDICA	POSITIVIDAD / HALLAZGO	COMENTARIO
Ergometría (Bruce)	Primera prueba si puede ejercitarse y el ECG es interpretable	Infradesnivel horizontal o descendente del ST ≥ 1 mm a 80 ms del punto J	Alto riesgo: ST ≥ 2 mm, precoz (< 5 METs), caída de PAS, TV
Ecocardiograma con dobutamina	ECG no interpretable (BCRI, marcapaso, HVI, digoxina) o no puede ejercitarse	Alteración nueva de la motilidad segmentaria	No exige ECG basal normal
Cintigrafía de perfusión (SPECT)	Igual que el eco de estrés; también viabilidad e isquemia en IC	Defecto reversible = isquemia; fijo = cicatriz	Estrés con ejercicio o fármacos (dipiridamol, adenosina)
AngioTAC coronario	Riesgo bajo a intermedio, para descartar enfermedad	Estenosis anatómica; VPN > 98%	Limita el calcio extenso y la taquicardia
Coronariografía	Alto riesgo en pruebas, angina refractaria, FEVI < 50% sin causa	Estenosis ≥ 70% (≥ 50% tronco) o FFR ≤ 0,80	Define stent o by-pass; acceso radial

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Angina típica, ECG normal	Ergometría	Troponinas o coronariografía directa
Ergometría con ST ≥ 2 mm	Coronariografía	Repetir otra prueba funcional
Angina + BCRI	Eco con dobutamina o SPECT	Ergometría convencional

REGLA DE ORO **Típica: 3 criterios de Diamond-Forrester** — Opresivo + esfuerzo + cede en reposo

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **1–2, 19–20, 22–25** (págs. 8, 10–11) · solucionario págs. 20, 22–23.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

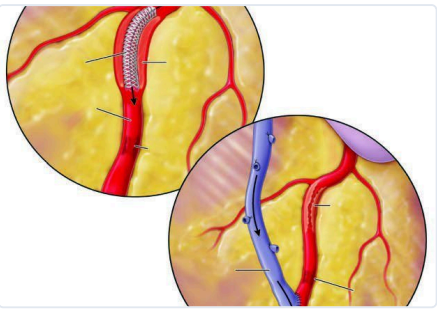
2.3 Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.001 Angina crónica estable — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- Aspirina **100 mg**/día y estatina de alta potencia (atorvastatina **40-80 mg**) reducen infarto y mortalidad: son obligatorias en todos; meta c-LDL < **55 mg/dL** y reducción **≥ 50%**.
- IECA o ARA II obligatorios si hay HTA, diabetes, ERC o FEVI **≤ 40%**.
- **Primera línea antianginosa**: betabloqueador cardioselectivo (bisoprolol **5-10 mg**), con meta de FC de reposo de **55-60 lpm**.
- Si el betabloqueador está contraindicado (asma grave, bloqueo AV, bradicardia): amlodipino (o diltiazem/verapamilo sin betabloqueador).
- Nitroglicerina sublingual **0,6 mg** SOS, hasta 3 dosis cada **5 minutos**; prohibida con sildenafil (**24 h**) o tadalafil (**48 h**).



STENT FRENTE A BY-PASS
Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 273-5

ALGORITMO · ANGINA CRÓNICA ESTABLE: TRATAMIENTO Y REVASCULARIZACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

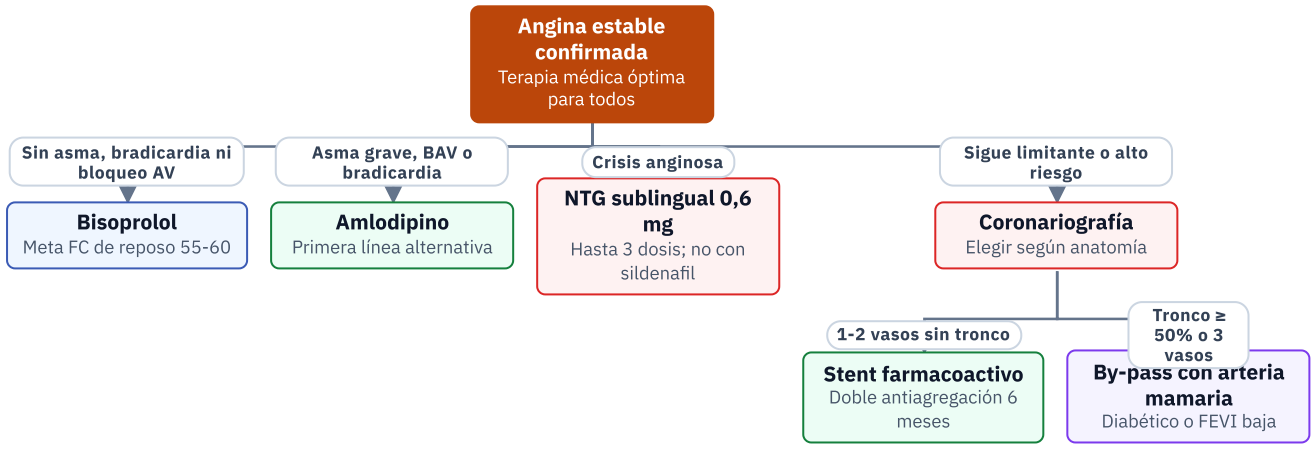


TABLA 2.3 · TABLA 2.3.A · ESQUEMA DE TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA EN LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE (NORMA TÉCNICA MINSAL)

PILAR FARMACOLÓGICO	FÁRMACO DE 1.ª ELECCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR DIARIA	OBJETIVO CLÍNICO / META
1. Antiagregación	Aspirina (alternativa: clopidogrel 75 mg)	100 mg/día VO, indefinida	Inhibe la COX-1 plaquetaria; reduce infarto y muerte
2. Hipolipemiante potente	Atorvastatina / rosuvastatina	40-80 mg/día / 20-40 mg/día VO	Estabiliza la placa; meta c-LDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50%
3. Bloqueador del SRAA	Enalapril / losartán	10-20 mg/día (hasta c/12 h) / 50-100 mg/día	Obligatorio si HTA, diabetes, ERC o FEVI ≤ 40%
4. Antianginoso de 1.ª línea	Bisoprolol / atenolol / metoprolol succinato	5-10 mg / 50-100 mg / según presentación	Bloqueo beta-1; meta FC de reposo 55-60 lpm
5. Antianginoso de 2.ª línea	Amlodipino (o diltiazem/verapamilo sin BB)	5-10 mg/día VO	Vasodilatación coronaria; alivio sintomático
6. Nitratos	Nitroglicerina SL; isosorbide de acción larga	0,6 mg SOS (hasta 3 dosis) / 20 mg c/12 h	Alivio de la crisis en < 5 min; prohibidos con sildenafil o tadalafil

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Qué reduce la mortalidad	Aspirina y estatina de alta potencia	Nitratos, diltiazem o trimetazidina
Angina + asma grave	Amlodipino	Bisoprolol, atenolol o propranolol
Diabetes, HTA, ERC o FEVI ≤ 40%	Agregar IECA o ARA II	Omitirlo

REGLA DE ORO **Aspirina 100 mg + atorvastatina 40-80 mg** — LDL < 55; IECA o ARA II según el caso

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **21** (pág. 10) · solucionario pág. 23.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

2.4 SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.001 Angina inestable — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El SCASEST es un trombo blanco suboclusivo**: la angina inestable no eleva la troponina; el IAMSEST sí, con curva sobre el percentil 99.
- Una primera troponina y un ECG normales no descartan angina inestable: se repite la troponina (0/**1 h**) y el ECG.
- **Angina inestable (Braunwald)**: de reposo (> **20 min**), de reciente comienzo (clase III-IV en **2 meses**), en crescendo y post-IAM (< **2 semanas**).
- **Doble antiagregación**: aspirina **250-500 mg** masticada + ticagrelor **180 mg** (clopidogrel **300-600 mg** si no se puede); anticoagulante: fondaparinux **2,5 mg** (menor sangrado) o enoxaparina **1 mg/kg** c/**12 h**.
- La fibrinólisis está contraindicada en el SCASEST.

ALGORITMO · SÍNDROME CORONARIO SIN SUPRADESNIVEL: DEL ECG A LA CORONARIOGRAFÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

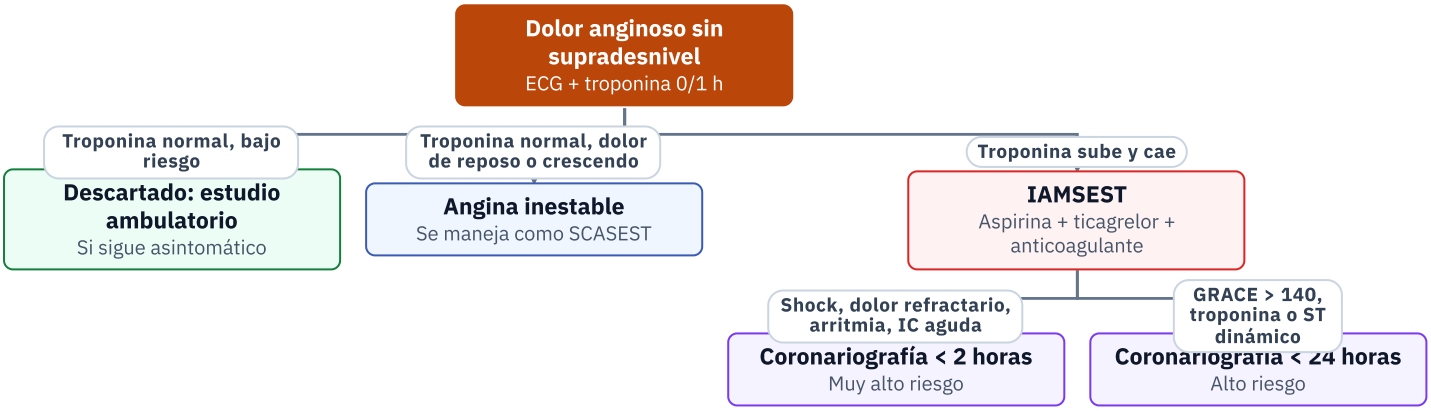


TABLA 2.4 · TABLA 2.4.A · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO INMEDIATO EN EL SCASEST (DOSIS DEL ADULTO)

FÁRMACO / VÍA	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIS DE MANTENCIÓN	ROL TERAPÉUTICO Y ADVERTENCIAS
Aspirina VO	250 a 500 mg masticada	100 mg/día VO, indefinida	Inhibe la COX-1; antiagregación universal inmediata
Ticagrelor VO (1.ª línea)	180 mg de carga	90 mg cada 12 horas VO	Inhibidor P2Y12 potente; superior al clopidogrel; contraindicado con hemorragia intracraneal previa
Clopidogrel VO (2.ª línea)	300 a 600 mg de carga	75 mg/día VO	Alternativa si el ticagrelor está contraindicado o hay anticoagulación oral
Fondaparinux SC	2,5 mg/día	2,5 mg/día SC	De elección por menor sangrado; no usar solo en la angioplastía
Enoxaparina SC	1 mg/kg cada 12 horas	1 mg/kg c/12 h (c/24 h si VFG < 30 mL/min)	Anticoagulante parenteral alternativo durante la hospitalización
Atorvastatina VO	80 mg la primera noche	80 mg/día VO	Estatina de alta potencia; estabilización precoz de la placa
Nitroglicerina / betabloqueador	SL o EV si dolor / oral precoz	Según clínica	Sin shock, bradicardia ni IC aguda; la fibrinólisis NO se usa

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Dolor de reposo, troponina normal	Angina inestable: tratar como SCASEST	Dar de alta
Infradesnivel + troponina que sube y cae	IAMSEST: DAPT + anticoagulante	Fibrinólisis
Antiagregante de elección	Ticagrelor 180 mg	Clopidogrel sin motivo

REGLA DE ORO **Angina inestable: troponina normal** — IAMSEST: sube y cae

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **27–29** (pág. 11) · solucionario págs. 23–24.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

2.5 SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES

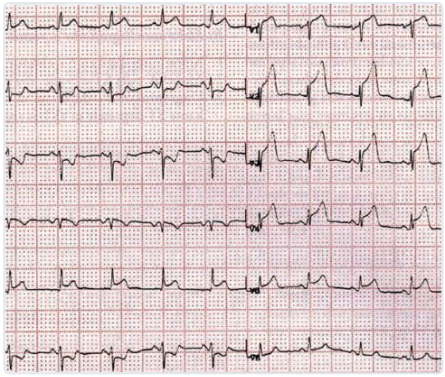
★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Trombolisis · Electrocardiograma

LO QUE TE PREGUNTAN

- ECG de 12 derivaciones interpretado en **≤ 10 minutos** ante todo dolor torácico; el SCACEST se reperfunde sin esperar la troponina.
- **Supradesnivel en ≥ 2 derivaciones contiguas**: **≥ 1 mm** en general; en V2-V3 **≥ 2 mm** (hombre **≥ 40 años**), **≥ 2,5 mm** (hombre < 40) y **≥ 1,5 mm** (mujer).
- **BCRI nuevo con clínica de infarto** = equivalente de SCACEST: reperfusión inmediata. Infradesnivel V1-V3 con R alta = IAM posterior (pedir V7-V9).
- **DII, DIII y aVF** = infarto inferior (coronaria derecha): tomar siempre V3R-V4R; en el infarto del VD, volumen y nada de nitratos, diuréticos ni morfina.
- Angioplastía primaria si se puede hacer en **≤ 120 min** desde el diagnóstico (meta puerta-balón **≤ 90 min**); si no, fibrinólisis en **≤ 30 min** y traslado.



IAM ANTERIOR: SDST V1-V5
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 178

ALGORITMO · INFARTO CON SUPRADESNIVEL DEL ST: DEL DOLOR A LA REPERFUSIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

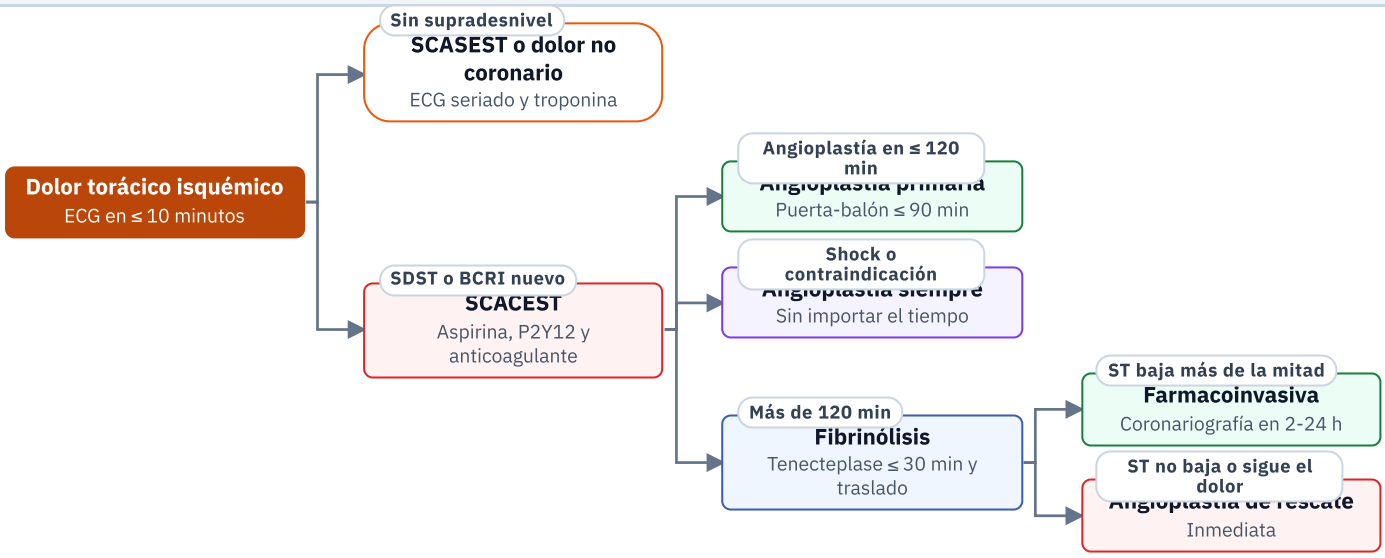


TABLA 2.5 · TERRITORIOS DEL IAM CON SUPRADESNIVEL DEL ST: DERIVACIONES, IMAGEN ESPECULAR Y ARTERIA CULPABLE

TERRITORIO	DERIVACIONES CON SUPRADESNIVEL	IMAGEN ESPECULAR (INFRADESNIVEL)	ARTERIA CULPABLE HABITUAL
Anterior / anteroseptal	V1-V4	DIII, aVF	Descendente anterior (DA)
Anterior extenso	V1-V6, DI, aVL	DII, DIII, aVF	DA proximal (peor pronóstico)
Lateral (alto)	DI, aVL, V5-V6	DII, DIII, aVF	Circunfleja o rama diagonal
Inferior	DII, DIII, aVF (DIII > DII)	DI, aVL	Coronaria derecha (80-90%)
Posterior	V7-V9 (≥ 0,5 mm)	V1-V3 con R alta y T positiva	Circunfleja o coronaria derecha
Ventrículo derecho	V3R-V4R (≥ 1 mm) + inferior	DI, aVL	Coronaria derecha proximal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
SDST en ECG, troponina pendiente	Reperfundir ya	Esperar la troponina
BCRI nuevo con dolor típico	Igual que SDST: reperfundir	Pedir enzimas o ecocardiograma
Infra V1-V3 con R alta	Pedir V7-V9: posterior	Tratarlo como SCASEST

REGLA DE ORO **ECG ≤ 10 min; no esperar troponina** — Clínica + ECG = diagnóstico

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **46, 48** (pág. 13) · solucionario pág. 26.

Clase 2.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

2.6 Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal

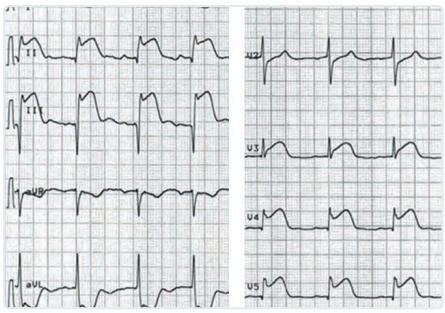
★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

También: Ecocardiografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Infarto inferior**: tomar siempre V3R-V4R; ST **≥ 1 mm** en V4R = infarto del VD.
- **Infarto del VD**: hipotensión + yugulares + pulmón limpio; se trata con volumen y están PROHIBIDOS nitratos, diuréticos y morfina.
- **Complicación temprana más frecuente**: arritmias ventriculares (la FV es la principal causa de muerte prehospitalaria); el infarto inferior da bradicardia y BAV transitorios.
- **Rotura de papilar (días 3-7, inferior)**: edema pulmonar + soplo holosistólico apical a la axila → eco, BCPIAo y cirugía mitral.
- **Rotura del tabique**: soplo pansistólico rudo en barra con frémito esternal bajo → Doppler y cirugía de cierre.



ST ELEVADO EN V3R-V4R
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 172

ALGORITMO · INFARTO QUE SE DETERIORA: DEL HALLAZGO AL DIAGNÓSTICO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

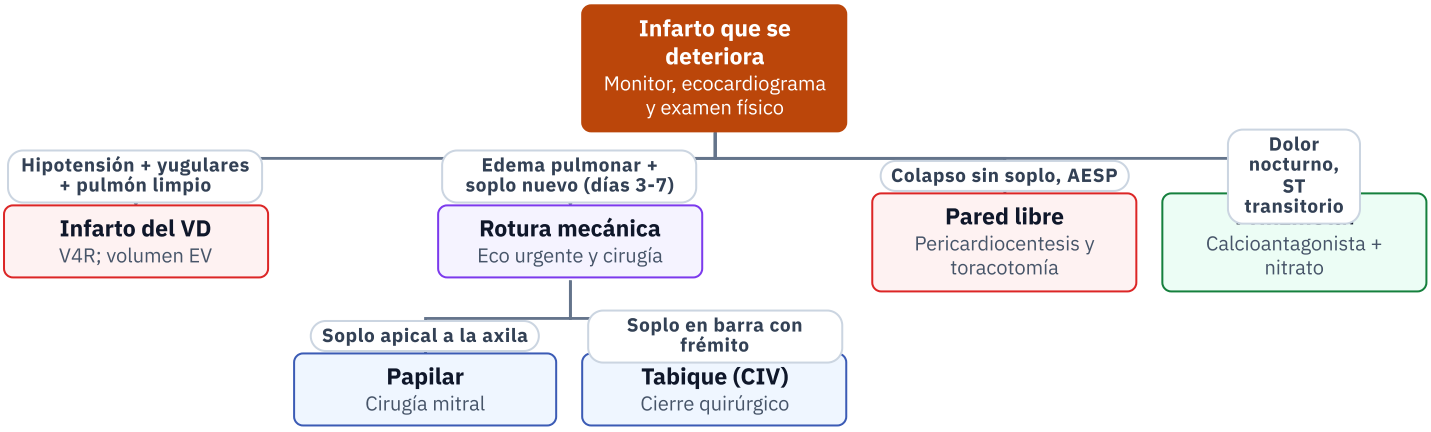


TABLA 2.6 · TABLA 2.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS COMPLICACIONES DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO

COMPLICACIÓN	INFARTO HABITUAL Y MOMENTO	HALLAZGO SEMIOLÓGICO CLAVE	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Infarto del ventrículo derecho	Inferior, desde las primeras horas	Hipotensión + yugulares + pulmón limpio; V4R ≥ 1 mm	Volumen; reperfusión; NO nitratos, diuréticos ni morfina
Rotura de músculo papilar	Inferior, días 3-7	Edema pulmonar súbito + soplo holosistólico apical a la axila	BCPIAo + cirugía mitral urgente
Rotura del tabique (CIV)	Anterior o inferior, días 3-7	Soplo pansistólico rudo en barra + frémito esternal	Vasodilatadores y BCPIAo + cirugía de cierre
Rotura de pared libre	Anterior transmural, mujer anciana	Colapso súbito + disociación electromecánica	Pericardiocentesis y toracotomía de rescate
Aneurisma ventricular	Anterior extenso, semanas a meses	ST elevado persistente > 4-6 semanas; trombo mural	Anticoagulación; cirugía si síntomas
Angina de Prinzmetal	Sin infarto; dolor de reposo nocturno	ST elevado transitorio que se normaliza	Calcioantagonista + nitrato; NO betabloqueador no selectivo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Complicación temprana más frecuente	Arritmias ventriculares	Rotura de pared libre
ST elevado > 4-6 semanas	Aneurisma: anticoagular si hay trombo	Nuevo infarto
Infarto inferior + sildenafil	No dar nitroglicerina	Nitroglicerina para el dolor

REGLA DE ORO **Inferior: V3R-V4R; VD = volumen** — Sin nitratos, diuréticos ni morfina

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 2.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos

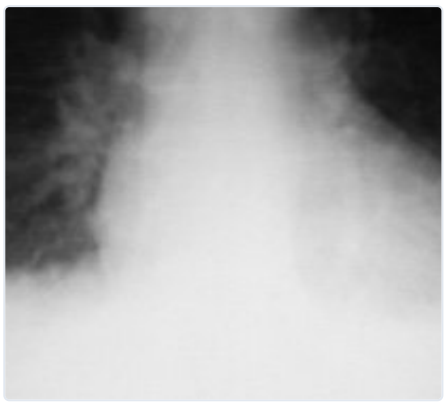
★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.018 Insuficiencia cardíaca — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Ecocardiografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Framingham**: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se confirma con ecocardiograma.
- **FEVI ≤ 40%** = IC-FEr; **41-49%** = IC-FEmr; **≥ 50%** con BNP alto y alteración estructural o diastólica = IC-FEp (mujer añosa, hipertensa, diabética, obesa).
- **Péptidos natriuréticos**: valor de descarte (ambulatorio BNP < 35 o NT-proBNP < 125; urgencia < 100 o < 300); suben con FA y falla renal, bajan con obesidad.
- El ecocardiograma Doppler es el examen de elección ante una IC sospechada: mide FEVI, grosor, válvulas, función diastólica y presión pulmonar.
- NYHA describe los síntomas de hoy (I a IV) y ACC/AHA el estadio evolutivo (A a D); la FEVI define el tratamiento.



CARDIOMEGALIA Y DERRAME
The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 11.24

ALGORITMO · INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA: DE LA DISNEA AL FENOTIPO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

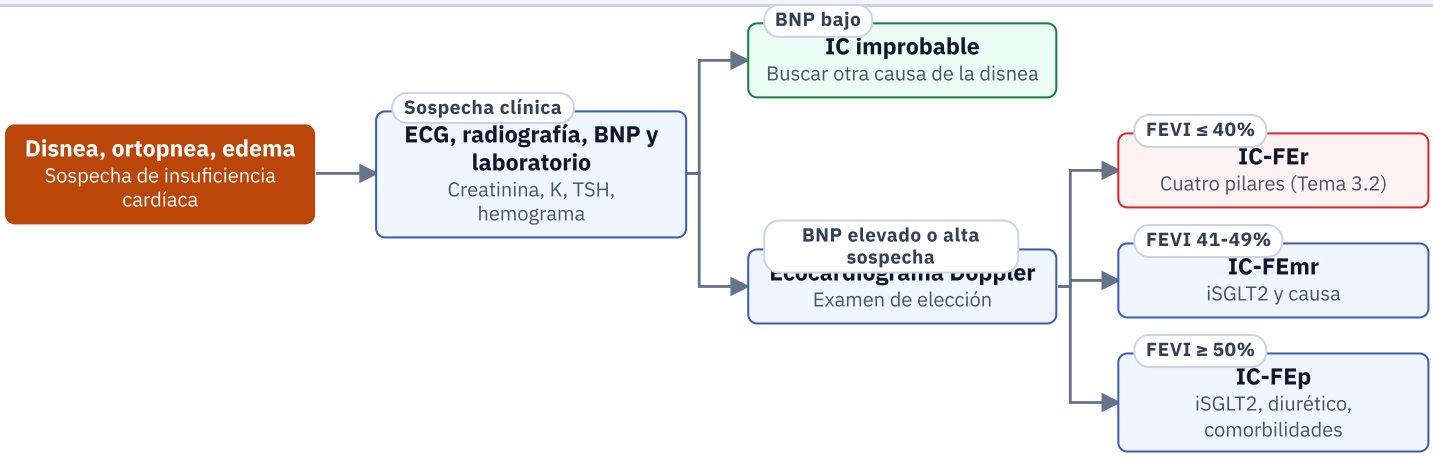


TABLA 3.1 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRAMINGHAM PARA INSUFICIENCIA CARDÍACA (2 MAYORES, O 1 MAYOR + 2 MENORES)

CRITERIOS MAYORES	CRITERIOS MENORES
Disnea paroxística nocturna u ortopnea	Edema bilateral de tobillos o piernas
Ingurgitación yugular a 45°	Tos nocturna
Crépitos pulmonares	Disnea de esfuerzos habituales
Cardiomegalia (índice cardiotorácico > 0,50)	Hepatomegalia
Edema agudo de pulmón	Derrame pleural
Tercer ruido (galope por R3)	Capacidad vital disminuida a un tercio
Reflujo hepatoyugular positivo; presión venosa central elevada	Taquicardia (frecuencia > 120 lpm)
Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días con diuréticos	—

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Disnea con ortopnea e infarto previo	Ecocardiograma primero	Coronariografía o test de esfuerzo
BNP bajo en un disneico	Descarta IC	Confirmar IC con un BNP alto
FEVI normal con síntomas y BNP alto	IC con fracción preservada	Decir que no es IC

REGLA DE ORO **Framingham: 2 mayores o 1 + 2 menores** — El diagnóstico es clínico

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **53** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.2 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.018 Insuficiencia cardíaca — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Los cuatro pilares que reducen la mortalidad en IC-FEr**: ARNI (o IECA/ARA II), betabloqueador con evidencia, espironolactona e iSGLT2; se inician precozmente y se titulan.
- **IECA → ARNI**: dejar **36 horas** sin IECA para evitar el angioedema; nunca juntos.
- **Betabloqueadores con evidencia**: bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato (no atenolol); se inician euvolémico y se duplica la dosis cada **2 semanas**.
- Espironolactona con K < 5,0 y VFG > 30; controlar K y creatinina a los **3 días**, a la semana y luego mensual; ginecomastia: eplerenona.
- Dapagliflozina o empagliflozina **10 mg** reducen hospitalizaciones y muerte cardiovascular con o sin diabetes; sin titulación.

ALGORITMO · INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN REDUCIDA: DEL DIAGNÓSTICO A LOS DISPOSITIVOS

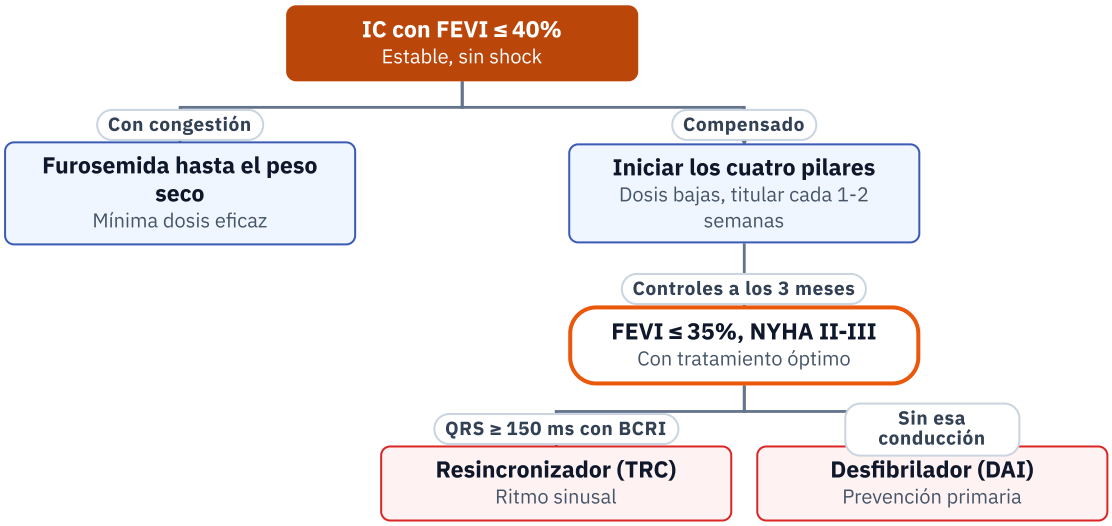


TABLA 3.2 · LOS CUATRO PILARES DE LA IC CON FRACCIÓN REDUCIDA: FÁRMACO, DOSIS INICIAL Y DOSIS META

PILAR	FÁRMACO	DOSIS INICIAL	DOSIS META
1. ARNI	Sacubitrilo / valsartán	24/26 o 49/51 mg cada 12 h (lavado de 36 h tras IECA)	97/103 mg cada 12 h
1. IECA (alternativa)	Enalapril (o captopril, lisinopril)	2,5 mg cada 12 h	10-20 mg cada 12 h
1. ARA II (si hay tos)	Losartán o candesartán	25-50 mg/día · 4-8 mg/día	150 mg/día · 32 mg/día
2. Betabloqueador	Bisoprolol · carvedilol · metoprolol succinato	1,25 mg/día · 3,125 mg c/12 h · 12,5-25 mg/día	10 mg/día · 25 mg c/12 h (50 si > 85 kg) · 200 mg/día
3. Antagonista mineralocorticoide	Espironolactona (o eplerenona)	12,5-25 mg/día (K < 5,0; VFG > 30)	25-50 mg/día
4. iSGLT2	Dapagliflozina o empagliflozina	10 mg/día	10 mg/día (sin titulación)
Diurético (síntomas)	Furosemida	20-40 mg/día	La mínima que mantenga el peso seco

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
IC con nifedipino	Suspender el nifedipino	Suspender el IECA
Reemplazar carvedilol por atenolol	No hacerlo	Cualquier betabloqueador sirve
IC con creatinina alta y digoxina	Es la menos adecuada	Usarla para mejorar la sobrevida

REGLA DE ORO **ARNI o IECA; betabloqueador; espironolactona; iSGLT2** — Se inician y se titulan

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

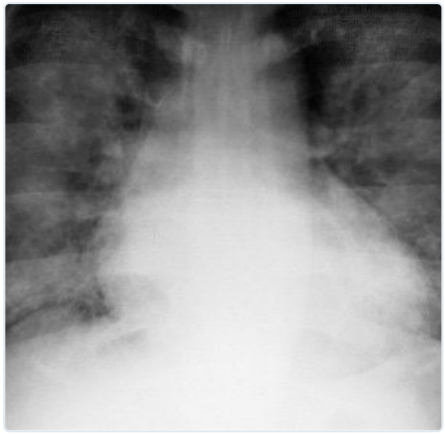
3.3 Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.005 Insuficiencia cardíaca aguda — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La ICA y el EAP son emergencias**: sentar al paciente, oxígeno si $SatO_2$ < **90%**, monitor, vía y exámenes en paralelo, sin esperar los resultados.
- La VNI (CPAP **5-10 cm**H_2O) es la medida de primera línea que más reduce la intubación en el EAP cardiogénico.
- Nitroglicerina EV es el vasodilatador de elección con PAS **≥ 110 mmHg**; está contraindicada con PAS < 90-100, infarto del VD, estenosis aórtica grave o sildenafil reciente.
- Furosemida EV **20-40 mg** (o **1-2,5 veces** la dosis oral habitual); evaluar diuresis a las **2 horas** y duplicar si no responde; no usarla en el perfil frío y seco.
- Morfina de rutina, betabloqueador intravenoso y calcioantagonista no se indican en el EAP; el betabloqueador crónico se continúa salvo shock.



EDEMA ALVEOLAR FLORIDO
The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 11.26

ALGORITMO · EDEMA AGUDO DE PULMÓN: DE LA URGENCIA A LA ESTABILIZACIÓN

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

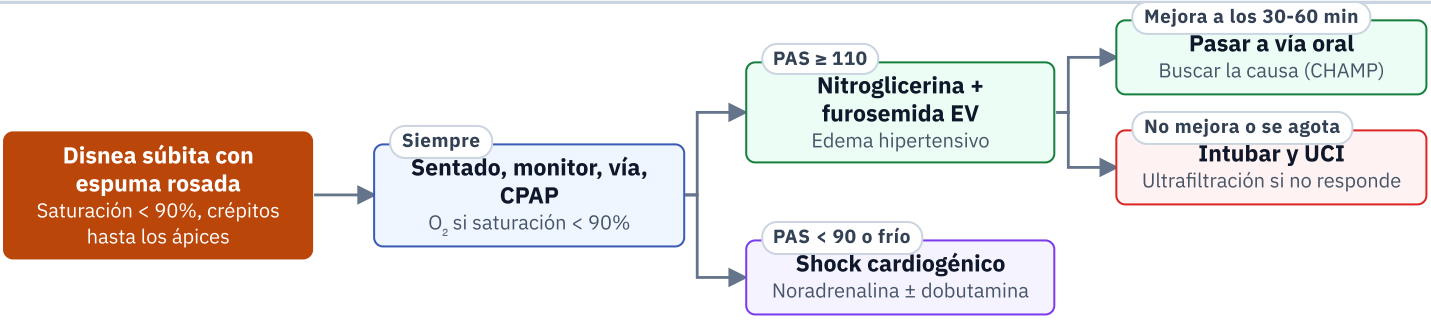


TABLA 3.3 · PERFILES HEMODINÁMICOS DE FORRESTER (CLÍNICOS) EN LA IC AGUDA Y SU TRATAMIENTO

PERFIL	PERFUSIÓN	CONGESTIÓN	TRATAMIENTO INICIAL
A · caliente y seco	Adecuada (extremidades tibias)	Ausente (campos limpios)	Mantener el tratamiento de base
B · caliente y húmedo (EAP clásico)	Adecuada (PA normal o alta)	Presente (crépitos, ortopnea, yugulares)	VNI (CPAP) + nitroglicerina EV + furosemida EV
L · frío y seco	Mala (extremidades frías)	Ausente (sin crépitos)	Volumen con cautela y causa del bajo gasto
C · frío y húmedo (shock cardiogénico)	Mala (hipotensión, oliguria)	Presente (congestión marcada)	Noradrenalina ± dobutamina; UCI; reperfusión si IAM

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
EAP con $SatO_2$ 82%	CPAP	Cánula nasal o intubar de entrada
EAP con PA 190/100	Nitroglicerina EV + furosemida	Nifedipino o betabloqueador
Paciente ansioso con EAP	No dar morfina de rutina	Morfina para calmar

REGLA DE ORO **Sentado, O_2 si < 90%, CPAP** — La VNI evita la intubación

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **47, 49** (pág. 13) · solucionario pág. 26.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.4 Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.007 Shock — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Insuficiencia cardíaca aguda

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Shock** = hipoperfusión: oliguria, confusión, piel fría o moteada, lactato > 2 mmol/L; la hipotensión (PAS < 90 o PAM < 65) puede faltar al inicio.
- **Cuatro tipos**: cardiogénico (gasto bajo, PCP alta, RVS alta), hipovolémico (gasto bajo, PCP baja, RVS alta), distributivo (gasto alto, RVS baja, piel caliente) y obstructivo (gasto bajo, PVC alta, yugulares ingurgitadas con pulmones limpios).
- **Causa principal del shock cardiogénico**: infarto agudo del miocardio (Killip IV); descartar una complicación mecánica con ecocardiograma.
- **El tratamiento que cambia la sobrevida es la reperfusión**: angioplastía primaria sin importar el tiempo de evolución.
- **Vasopresor de primera línea**: noradrenalina (menos arritmias y menor mortalidad que la dopamina); inótropo: dobutamina.

ALGORITMO · SHOCK: DEL PACIENTE HIPOTENSO AL TRATAMIENTO

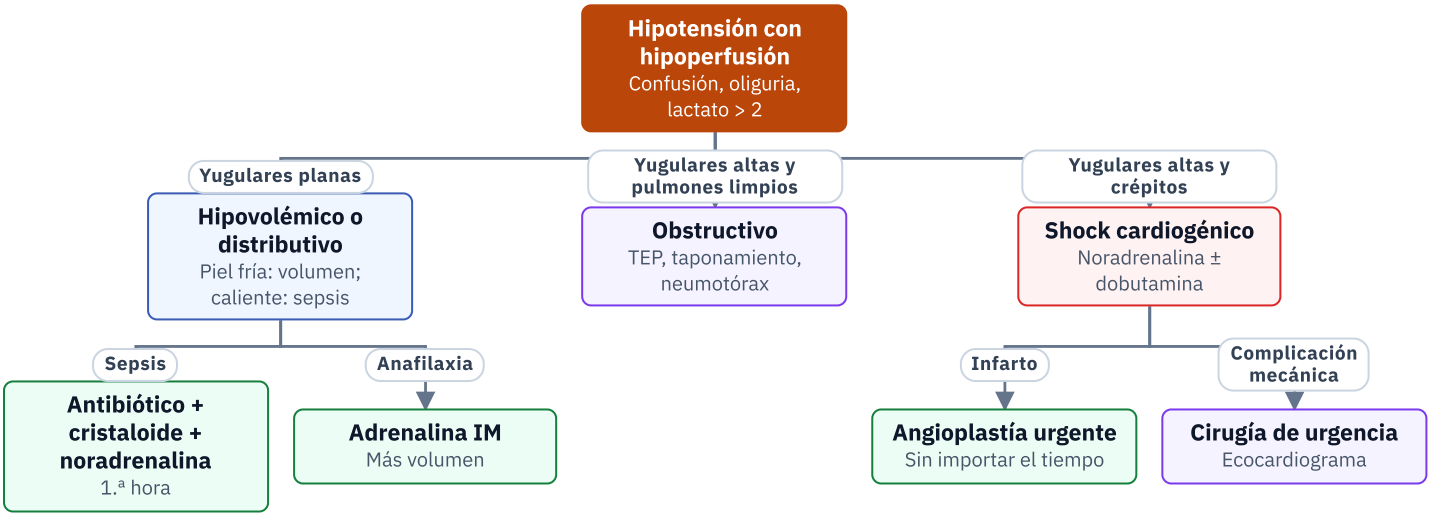


TABLA 3.4 · PATRÓN HEMODINÁMICO DE LOS CUATRO TIPOS DE SHOCK

TIPO DE SHOCK	GASTO CARDÍACO	PRESIÓN DE LLENADO (PCP / PVC)	RESISTENCIA VASCULAR	PIEL Y YUGULARES
Cardiogénico	Muy bajo ↓	PCP alta ↑	Alta ↑	Piel fría y sudorosa; yugulares altas; crépitos
Hipovolémico	Bajo ↓	PCP y PVC bajas ↓ ↓	Alta ↑	Piel fría; mucosas secas; yugulares planas
Distributivo (séptico, anafiláctico)	Alto o normal ↑	Baja o normal	Baja ↓ ↓	Piel caliente y enrojecida (al inicio); yugulares bajas
Obstructivo (TEP, taponamiento, neumotórax)	Muy bajo ↓	PVC alta; PCP baja en TEP, alta en taponamiento	Alta ↑	Piel fría; yugulares muy altas; pulmones limpios

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Gasto alto, resistencia baja, piel caliente	Shock distributivo	Shock cardiogénico
Gasto bajo, presión de llenado alta, crépitos	Shock cardiogénico	Dar volumen
Yugulares planas, piel fría, sangrado	Hipovolémico: volumen	Noradrenalina sola

REGLA DE ORO **Hipoperfusión, no solo hipotensión** — Lactato > 2, oliguria, confusión

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **43–45** (pág. 13) · solucionario págs. 25–26.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.5 Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.020 Miocardiopatías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- MCH: hipertrofia ventricular asimétrica inexplicada (septo **≥ 15 mm**), enfermedad autosómica dominante del sarcómero (1 de cada 500); primera causa de muerte súbita del deportista joven.
- **Clínica**: disnea de esfuerzo, angina, palpitaciones, síncope de esfuerzo y antecedente familiar de muerte súbita; muchos son asintomáticos.
- El soplo eyectivo de la MCH AUMENTA con Valsalva, de pie y nitratos (menor volumen) y DISMINUYE en cuclillas, al elevar las piernas y con handgrip; en la estenosis aórtica ocurre lo contrario.
- ECG: HVI, ondas Q profundas inferolaterales, T invertidas gigantes; el ecocardiograma confirma (septo, SAM, gradiente **≥ 30 mmHg**).
- **Tratamiento**: betabloqueador (o verapamilo) de primera línea; mavacamten o disopiramida en la obstructiva; miectomía septal si el gradiente es **≥ 50 mmHg** y persisten los síntomas.



SEPTO ASIMÉTRICO (PIEZA)
Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-15

ALGORITMO · MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA: DEL SÍNCOPE DE ESFUERZO AL MANEJO

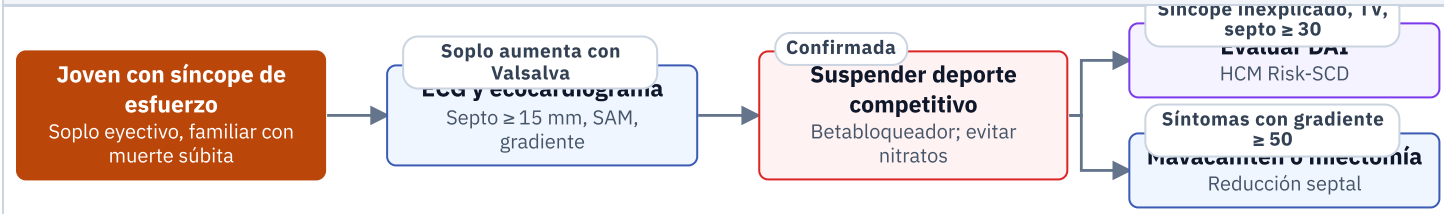


TABLA 3.5 · EFECTO DE LAS MANIOBRAS SOBRE EL SOPLO SISTÓLICO: MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA, ESTENOSIS AÓRTICA, INSUFICIENCIA MITRAL Y PROLAPSO MITRAL

MANIOBRA (EFECTO SOBRE EL RETORNO VENOSO)	MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA	ESTENOSIS AÓRTICA	INSUFICIENCIA MITRAL	PROLAPSO MITRAL
Valsalva (disminuye la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Casi no cambia	Aumenta (el clic se adelanta)
De pie (disminuye la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Disminuye levemente	Aumenta
Cuclillas (aumenta la precarga y la poscarga)	DISMINUYE	Aumenta	Aumenta	Disminuye
Elevar las piernas (aumenta la precarga)	DISMINUYE	Aumenta	Casi no cambia	Disminuye
Handgrip isométrico (aumenta la poscarga)	DISMINUYE	Disminuye	AUMENTA	Disminuye
Nitrito de amilo o nitratos (disminuyen la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Disminuye	Aumenta

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Síncope de esfuerzo, soplo eyectivo, hermano fallecido	Miocardiopatía hipertrófica	Brugada o QT largo
Soplo que aumenta con Valsalva y de pie	MCH	Estenosis aórtica
MCH obstructiva con disnea	Betabloqueador	Nitratos, diuréticos o digoxina

REGLA DE ORO **Síncope de esfuerzo + familiar con MS** — Soplo que AUMENTA con Valsalva y de pie

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **26** (pág. 11) · solucionario pág. 23.

Clase 3.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.6 Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
5 preguntas reales 2013–2025

Media-alta · Diagnóstico de la miocardiopatía dilatada, causas (alcohol, Chagas, antraciclinas, periparto), amiloidosis como causa de la restrictiva y la resonancia magnética en la miocarditis

1.01.1.020 Miocardiopatías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

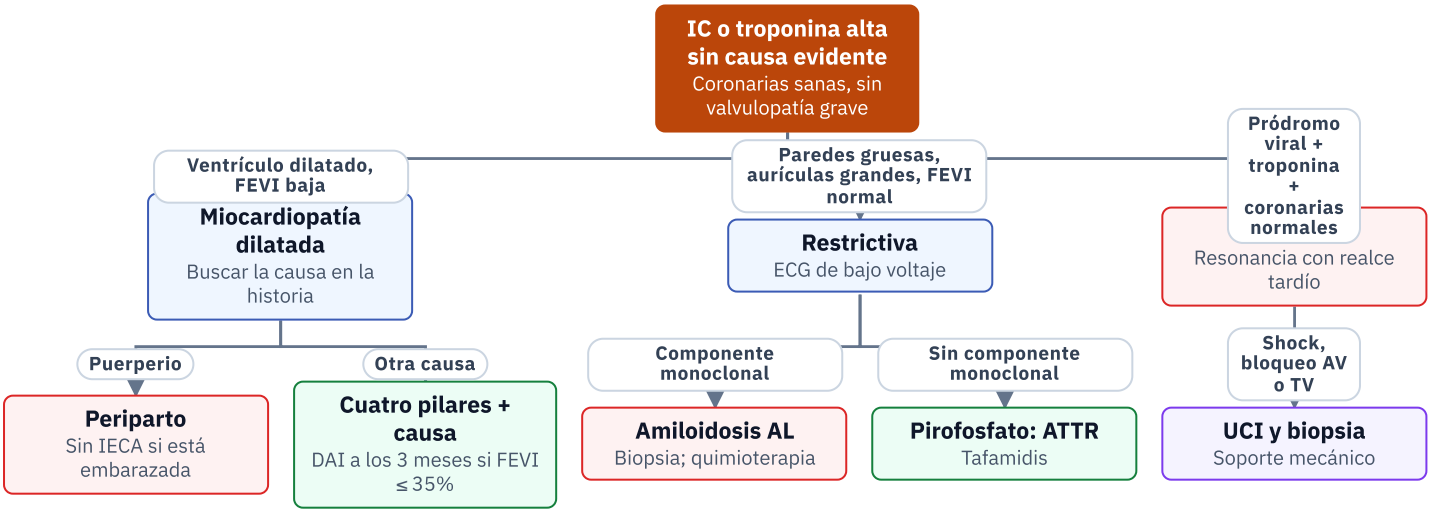
- **Miocardiopatía** = enfermedad del músculo no explicada por coronarias, válvulas ni hipertensión; se clasifica por el fenotipo del ecocardiograma (dilatada, hipertrófica, restrictiva, arritmogénica).
- **Dilatada**: IC en joven con ventrículo esférico y FEVI < **40%**; causas: idiopática/familiar, alcohol (reversible), Chagas, antraciclinas, periparto, viral y taquicardiomiopatía; tratar con los cuatro pilares.
- **Chagas crónico**: BRD + hemibloqueo anterior izquierdo, aneurisma apical, arritmias, tromboembolia y megaórganos; serología en zona endémica.
- **Periparto**: último mes de embarazo hasta **5 meses** posparto; disnea con R3 y crépitos; IECA, ARA II y espironolactona solo después del parto; bromocriptina.
- **Restrictiva**: paredes gruesas, aurículas gigantes, FEVI normal, IC derecha y bajo voltaje en el ECG; amiloidosis es la causa más frecuente (tafamidis en ATTR); evitar digoxina y betabloqueador.
- **Restrictiva vs constrictiva**: pericardio calcificado, golpe pericárdico e interdependencia ventricular orientan a la constrictiva (se cura con pericardiectomía).
- **Miocarditis**: pródromo viral + dolor + troponina elevada + coronarias normales; la resonancia con realce tardío confirma; la biopsia solo en las formas graves.



DILATADA: PIEZA EXPLANTADA
Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-2

ALGORITMO · MIOCARDIOPATÍAS Y MIOCARDITIS: DE LA INSUFICIENCIA SIN CAUSA AL DIAGNÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 3.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

3.6 Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 3.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MIOCARDIOPATÍAS Y LA MIOCARDITIS

ENTIDAD	MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN	PISTA CLÍNICA Y EXAMEN DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO O ADVERTENCIA
Hipertrófica (Tema 3.5)	Hipertrofia asimétrica del septo ≥ 15 mm; FEVI normal o alta	Síncope de esfuerzo, soplo que aumenta con Valsalva · ecocardiograma	Betabloqueador; prohibidos nitratos, digoxina y diuréticos altos
Dilatada	Dilatación esférica de las cavidades; FEVI < 40%	IC en joven, alcohol, Chagas, antraciclinas · ecocardiograma + coronarias	Cuatro pilares de la IC-FEr; abstinencia de alcohol; DAI si FEVI ≤ 35%
Restrictiva	Paredes gruesas, aurículas gigantes, ventrículos normales; FEVI conservada	IC derecha, ECG de bajo voltaje · ecocardiograma, resonancia, pirofosfato	Tratar la causa (tafamidis en ATTR); diuréticos con cuidado; evitar digoxina
Miocarditis aguda	Edema miocárdico; función normal a muy deprimida	Pródromo viral, dolor, troponina ↑, coronarias normales · resonancia con realce tardío	Soporte; sin corticoides de rutina; reposo deportivo 3-6 meses
Periparto	Dilatación con FEVI < 45%	Último mes del embarazo a 5 meses del parto, R3 y crépitos · ecocardiograma	Tratamiento de la IC compatible con la gestación; bromocriptina; anticoagular si FEVI < 30%
Chagas crónica	Dilatación con aneurisma apical	Zona endémica, BRD + HFAI, serología · ecocardiograma	IC, antiarrítmicos, marcapaso o DAI; evaluar antiparasitario

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
IC en joven con R3, choque lateral y soplo apical	Miocardiopatía dilatada	Miocardiopatía hipertrófica
Puérpera con disnea, R3 y crépitos	Miocardiopatía periparto	TEP o embolia amniótica
Equimosis periorbitaria + proteinuria + VHS alta	Amiloidosis	Nefrosis lipoidea

REGLA DE ORO **Dilatada: alcohol, Chagas, antraciclinas, periparto** — Tratar con los 4 pilares

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Cuando un paciente joven o de mediana edad llega con insuficiencia cardíaca y las coronarias están sanas, sin hipertensión ni valvulopatía que lo explique, estamos ante una miocardiopatía, una miocarditis o un tóxico. La respuesta correcta en el EUNACOM casi siempre es una pista de la historia: el alcohol, el viaje a una zona de Chagas, la quimioterapia con antraciclinas, el puerperio, la infección viral de hace dos semanas. El médico general debe sospechar la entidad, pedir el examen de elección (ecocardiograma primero, resonancia después), evitar el error de la coronariografía como único estudio y derivar con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya iniciado.

TABLA 3.6.B · TRATAMIENTO Y CONTROLES POR ENTIDAD

ENTIDAD	TRATAMIENTO	CONTROLES	DERIVA O COMPLICA SI…
Dilatada	IECA/ARNI + betabloqueador + espironolactona + iSGLT2; diurético mínimo	Ecocardiograma a los 3 meses; creatinina y potasio	FEVI ≤ 35%: DAI; BCRI con QRS ≥ 150: TRC; terminal: trasplante
Restrictiva (amiloidosis)	Tafamidis (ATTR) o quimioterapia (AL); diuréticos con cuidado	Péptidos natriuréticos, troponina, función renal	Sin digoxina ni betabloqueador; bloqueo AV: marcapaso
Miocarditis	Soporte, IC, antiarrítmicos; corticoides solo en formas específicas	ECG, Holter, ecocardiograma y resonancia a los 3-6 meses	Shock, bloqueo AV de alto grado o TV: UCI, biopsia y soporte mecánico
Periparto	Pilares de la IC adecuados a gestación y lactancia; bromocriptina	Ecocardiograma seriado hasta 12 meses	FEVI < 30%: anticoagular; sin recuperación: evitar nuevo embarazo

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 3.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.1 Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.01.1.021 Paciente con soplo — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco, irradiación, tono y grado de Levine; el grado IV o más tiene frémito y es siempre patológico.
- Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler; el sistólico inocente es suave (I-II), corto, sin frémito, con ruidos y ECG normales.
- **Inspiración profunda (Rivero-Carvallo)**: aumentan los soplos del corazón derecho (insuficiencia tricuspídea, estenosis pulmonar).
- **Valsalva y ponerse de pie**: disminuyen casi todos los soplos; solo aumentan la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso mitral (clic precoz, soplo más largo).
- **Cuclillas**: disminuye el soplo de la miocardiopatía hipertrófica y aumenta el de la estenosis aórtica; el clic del prolapso se retrasa.

ALGORITMO · PACIENTE CON SOPLO: DEL HALLAZGO A LA CONDUCTA

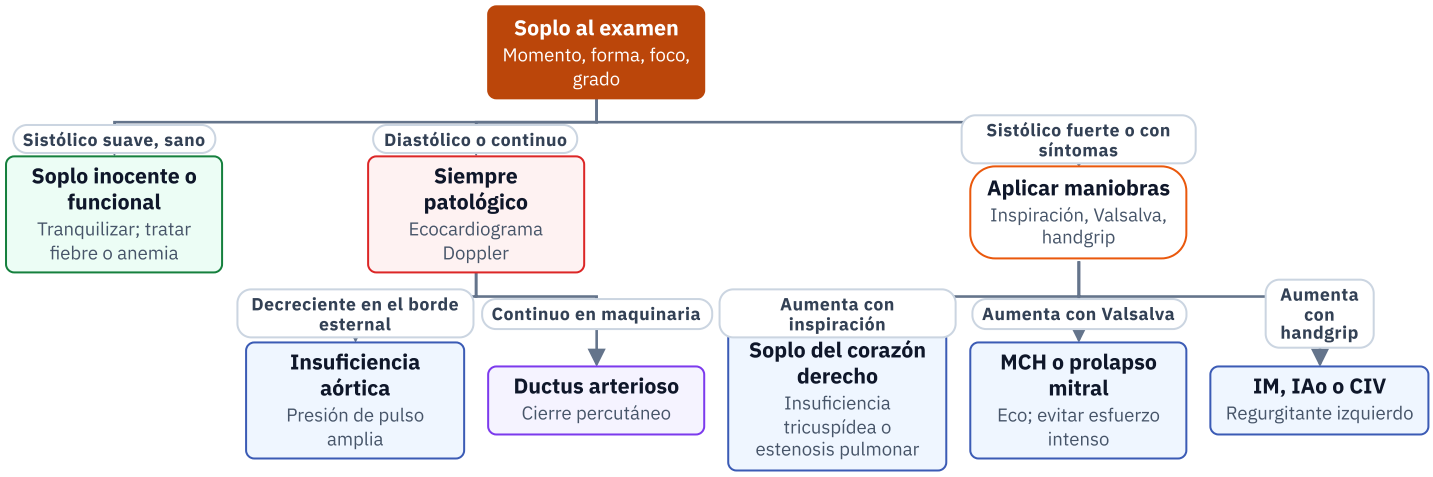


TABLA 4.1 · RESPUESTA DE LOS SOPLOS A LAS MANIOBRAS DINÁMICAS

MANIOBRA	EFECTO HEMODINÁMICO	SOPLOS QUE AUMENTAN	SOPLOS QUE DISMINUYEN
Inspiración profunda (Rivero-Carvallo)	Más retorno venoso derecho	Insuficiencia/estenosis tricuspídea, estenosis/insuficiencia pulmonar	Los izquierdos no cambian
Valsalva, de pie, nitrito de amilo	Menos precarga: VI más pequeño	Miocardiopatía hipertrófica obstructiva; prolapso mitral (clic precoz, soplo más largo)	Casi todos los demás (estenosis aórtica, insuficiencia mitral, CIV)
Cuclillas, elevación de piernas	Más precarga y más poscarga	Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral	Miocardiopatía hipertrófica obstructiva; prolapso (clic tardío, soplo corto)
Handgrip (empuñadura isométrica)	Más poscarga	Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, CIV	Estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Pausa postextrasistólica	Mayor llenado del VI	Estenosis aórtica	La insuficiencia mitral no cambia

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	PATRÓN	ERROR TÍPICO
Soplo holosistólico que aumenta al inspirar	Insuficiencia tricuspídea	Insuficiencia mitral
Clic mesosistólico que se adelanta al pararse	Prolapso mitral	Insuficiencia mitral clásica
Soplo continuo infraclavicular izquierdo	Ductus arterioso persistente	Comunicación interventricular

REGLA DE ORO **Momento, forma, foco, irradiación, grado** — Diastólico o continuo: siempre eco

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **82** (pág. 18) · solucionario pág. 30.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.2 Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular

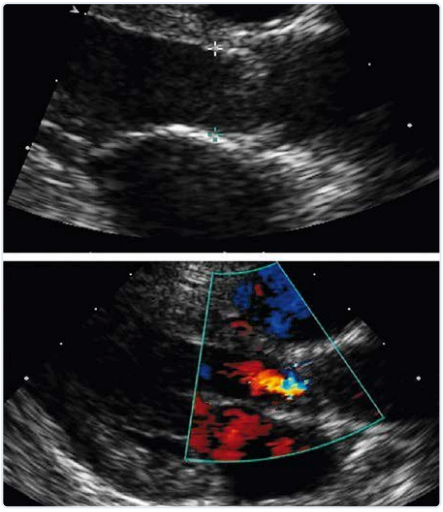
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.009 Estenosis aórtica — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Ecocardiografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Causas**: degenerativa calcificada en mayores de **70 años** y válvula bicúspide congénita (la más probable en menores de **65 años** sin fiebre reumática).
- **Tríada de síntomas con sobrevida sin cirugía**: angina (**5 años**), síncope (**3 años**) y disnea o insuficiencia cardíaca (**2 años**).
- **Semiología**: pulso parvus et tardus, frémito, soplo eyectivo en rombo irradiado a las carótidas y R2 apagado o único; R4 frecuente.
- El soplo de la estenosis aórtica disminuye con Valsalva y handgrip; el de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva aumenta con Valsalva.
- **Severa**: velocidad pico **≥ 4 m/s**, gradiente medio **≥ 40 mmHg** o AVA **≤ 1,0 cm²** (< **0,6 cm²**/m²). El ecocardiograma Doppler es el primer examen en el adulto mayor con soplo y angina o síncope.
- La prueba de esfuerzo está contraindicada en la estenosis severa sintomática; los vasodilatadores y diuréticos se usan con cautela.



ECO: ESTENOSIS AÓRTICA
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 2792

ALGORITMO · ESTENOSIS AÓRTICA: DEL SOPLO A LA INTERVENCIÓN

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

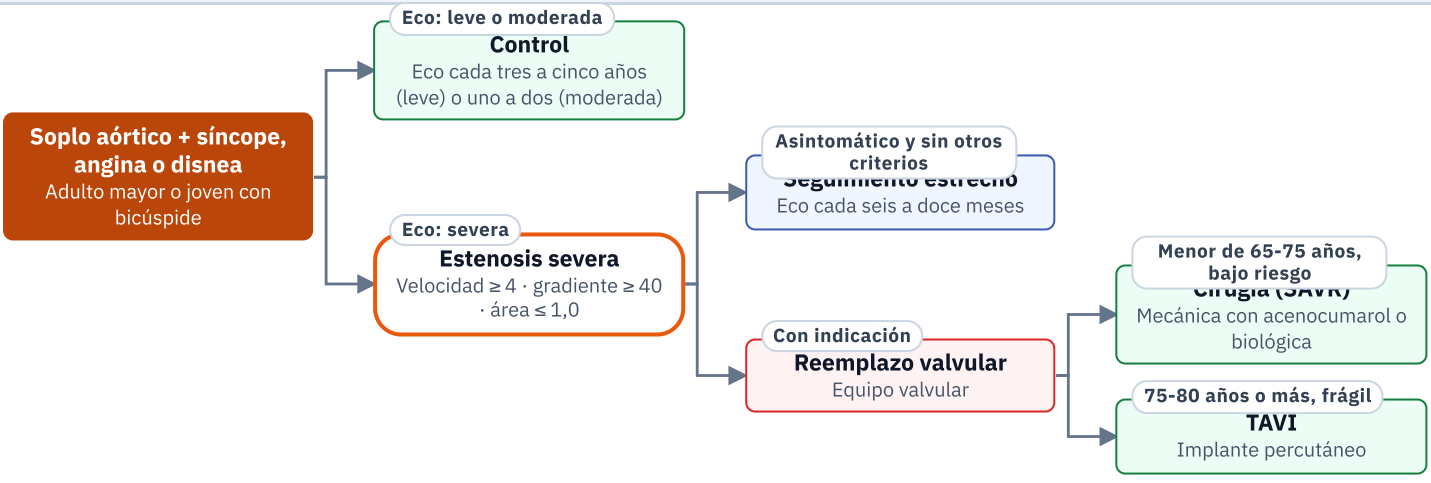


TABLA 4.2 · ESTRATIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD ECOCARDIOGRÁFICA DE LA ESTENOSIS AÓRTICA

PARÁMETRO HEMODINÁMICO	LEVE	MODERADA	SEVERA (CRITERIO DE INTERVENCIÓN)
Velocidad pico del chorro	2,6 a 2,9 m/s	3,0 a 3,9 m/s	≥ 4,0 m/s
Gradiente medio	< 25 mmHg	25 a 39 mmHg	≥ 40 mmHg
Área valvular aórtica (AVA)	> 1,5 cm²	1,0 a 1,5 cm²	≤ 1,0 cm² (indexada < 0,6 cm²/m²)
Cociente adimensional	> 0,50	0,25 a 0,50	< 0,25

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Anciano con angina y soplo sistólico	Ecocardiograma Doppler	Prueba de esfuerzo o coronariografía primero
Soplo eyectivo, R2 apagado, parvus et tardus	Estenosis aórtica	Miocardiopatía hipertrófica
Menor de 65 años sin fiebre reumática	Válvula bicúspide	Degeneración senil

REGLA DE ORO **Parvus et tardus, eyectivo a carótidas, R2 apagado** — Tríada: angina, síncope, disnea

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **34–36** (pág. 12) · solucionario págs. 24–25.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

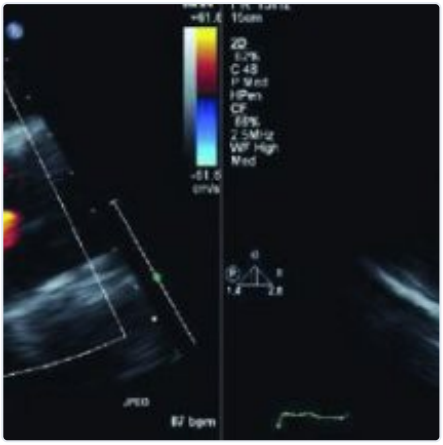
4.3 Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.017 Insuficiencia aórtica — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Presión de pulso amplia (por ejemplo 170/**45 mmHg**) con pulso saltón de Corrigan, Musset y Quincke es insuficiencia aórtica; el signo de Hill > **60 mmHg** es el más sensible de gravedad.
- El soplo es diastólico, decreciente y aspirativo, mejor audible con el paciente sentado e inclinado hacia delante, en espiración; el Austin Flint es un retumbo apical sin chasquido de apertura.
- **Causas**: raíz dilatada (hipertensión, Marfan, disección tipo A, sífilis, espondiloartritis) y valvulares (bicúspide, endocarditis, fiebre reumática).
- **Ecocardiograma Doppler color**: severa si vena contracta > **6 mm**, chorro > **65%** del tracto de salida, volumen regurgitante **≥ 60 mL** o fracción regurgitante **≥ 50%**.
- **El asintomático con VI normal no se opera**: vasodilatadores (IECA o dihidropiridínicos) con meta < 130/**80 mmHg** y ecocardiograma cada **6-12 meses**.



DOPPLER COLOR: IAO
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1889

ALGORITMO · INSUFICIENCIA AÓRTICA: DE LA PRESIÓN DIVERGENTE A LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

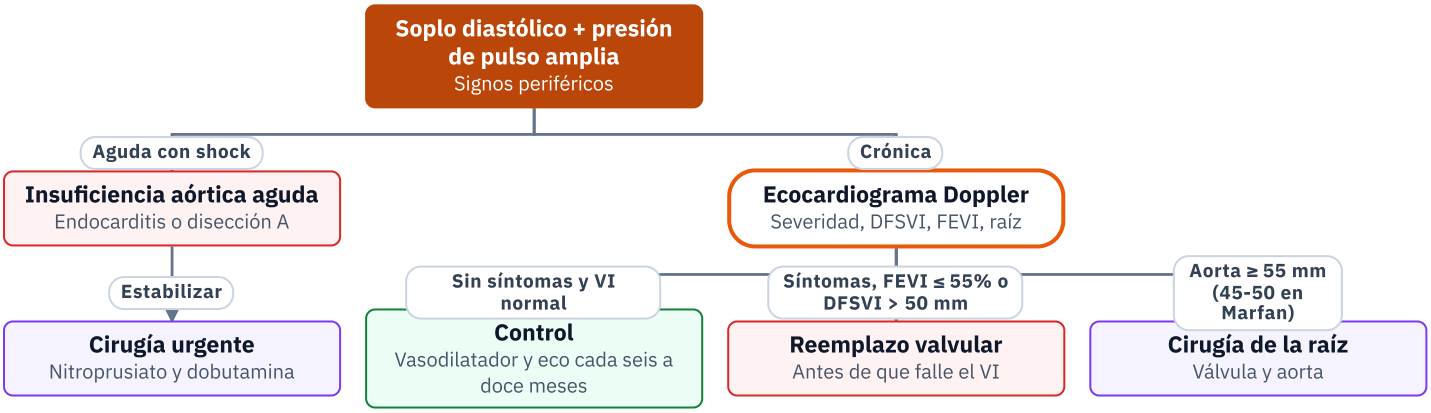


TABLA 4.3 · SIGNOS PERIFÉRICOS DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA CRÓNICA: EPÓNIMO Y HALLAZGO

SIGNO	HALLAZGO	MECANISMO
Corrigan (pulso saltón, céler)	Ascenso rápido y colapso brusco del pulso	Gran volumen eyectado y fuga diastólica
Musset	Cabeceo rítmico con cada latido	Pulsación transmitida a las carótidas
Quincke	Pulsación capilar visible en el lecho ungueal	Presión de pulso amplia
Müller	Pulsación sistólica de la úvula	Presión de pulso amplia
Traube	Ruido de pistoletazo sobre la femoral	Distensión brusca de la arteria
Duroziez	Doble soplo sistodiastólico al comprimir la femoral	Flujo anterógrado y retrógrado
Hill	Presión poplítea > braquial en > 60 mmHg	El más sensible para valorar la gravedad
Austin Flint	Retumbo mesodiastólico apical sin chasquido	El chorro choca contra la valva mitral anterior

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Asintomático, VI normal	Vasodilatador y control con eco	Operar de inmediato
FEVI ≤ 55% o DFSVI > 50 mm, sin síntomas	Reemplazo valvular	Seguir controlando
Marfan con aorta de 52 mm	Cirugía de la raíz aórtica	Betabloqueador en dosis altas

REGLA DE ORO **Presión divergente + Corrigan, Musset, Quincke** — Soplo diastólico decreciente

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **52** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 4.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.4 Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática

PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Alta · Criterios de Jones, tratamiento de la fiebre reumática (penicilina benzatina, aspirina, corticoides), profilaxis primaria y secundaria con su duración, semiología de la estenosis mitral, anticoagulación y valvuloplastía con puntaje de Wilkins

1.01.1.010 **Estenosis mitral** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Enfermedad reumática activa · Prevención de enfermedad reumática

LO QUE TE PREGUNTAN

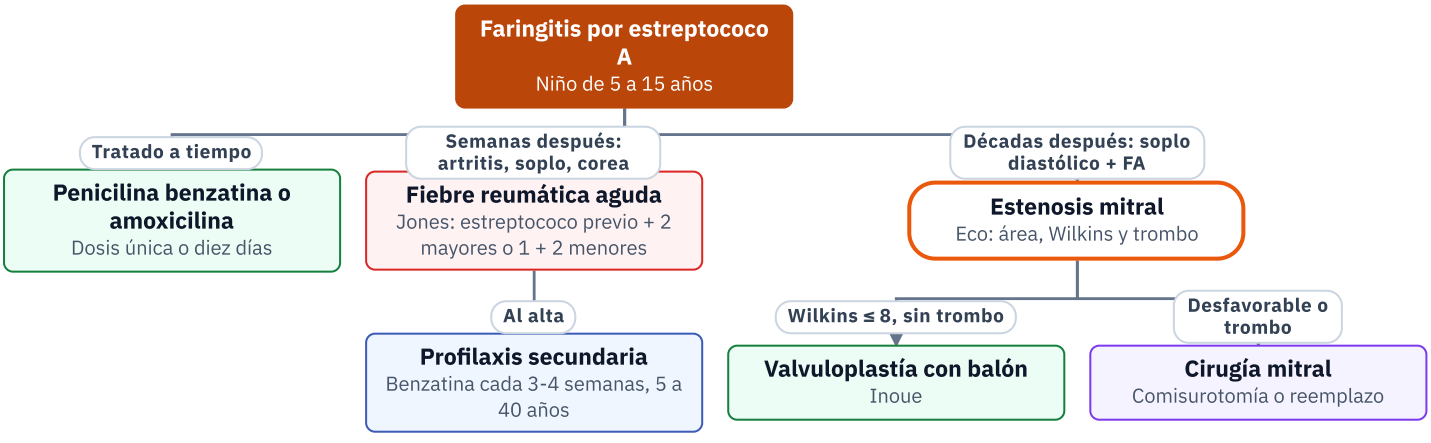
- **Fiebre reumática**: aparece **2-4 semanas** después de una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, en niños de **5 a 15 años**; la piel no la desencadena de forma clásica.
- **Jones**: evidencia de estreptococo previo + 2 criterios mayores, o 1 mayor + 2 menores. Mayores: carditis, poliartritis migratoria, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos.
- Corea y carditis indolente se diagnostican sin evidencia estreptocócica; la artritis responde de forma casi diagnóstica a la aspirina; la pancarditis es la única manifestación que deja secuelas.
- **Tratamiento**: penicilina benzatina **1.200.000 UI** IM dosis única, aspirina **80-100 mg/kg**/día para la artritis y prednisona **1-2 mg/kg**/día si hay carditis moderada o grave.
- **Prevención primaria**: tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con penicilina benzatina o amoxicilina **10 días**, dentro de los **9 días** del inicio.
- **Prevención secundaria**: penicilina benzatina **1.200.000 UI** IM cada **3-4 semanas**, **5 años** o hasta los 21 sin carditis; **10 años** o hasta los 21 con carditis; **10 años** o hasta los 40 con secuela valvular.
- **Estenosis mitral**: R1 intenso, chasquido de apertura y retumbo diastólico con refuerzo presistólico (desaparece en fibrilación auricular); aurícula izquierda dilatada y ventrículo normal.



ECO: ESTENOSIS MITRAL
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1890

ALGORITMO · FIEBRE REUMÁTICA Y ESTENOSIS MITRAL: DE LA FARINGITIS A LA VÁLVULA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **33, 66** (págs. 12, 16) · solucionario págs. 24, 28.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.4 Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 4.4 · CRITERIOS DE JONES MODIFICADOS (AHA 2015) PARA LA FIEBRE REUMÁTICA AGUDA

CRITERIOS MAYORES	CRITERIOS MENORES	REGLA DIAGNÓSTICA
Carditis (clínica o subclínica)	Fiebre (≥ 38,5 °C; ≥ 38 °C en riesgo alto)	2 mayores, o 1 mayor + 2 menores
Poliartritis migratoria (de grandes articulaciones)	Artralgias (poliartralgia; en riesgo alto, monoartralgia)	Siempre con evidencia de estreptococo previo (ASLO, anti-DNasa B, cultivo)
Corea de Sydenham	VHS ≥ 60 mm/h o PCR ≥ 3 mg/dL (en riesgo alto, VHS ≥ 30)	Corea y carditis indolente: sin necesidad de evidencia
Eritema marginado	PR prolongado (sin carditis)	Recurrencia: 2 mayores, 1 mayor + 1 menor o 3 menores
Nódulos subcutáneos	—	Dx diferencial: artritis séptica, reumatoide, lupus, endocarditis

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Faringitis estreptocócica del escolar	Penicilina benzatina o amoxicilina	Penicilina sódica endovenosa
Artritis migratoria + soplo apical + ASLO alto	Fiebre reumática: Jones	Artritis séptica o reumatoide
Corea meses después de una faringitis	Criterio mayor, sin evidencia estreptocócica	Exigir ASLO elevada

REGLA DE ORO **Estreptococo previo + 2 mayores, o 1 + 2 menores** — Corea y carditis indolente: excepción

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La fiebre reumática es la enfermedad que une la atención primaria con la cirugía cardíaca: un niño con dolor de garganta tratado a tiempo con una sola dosis de penicilina no la desarrolla, y un paciente que la sufrió y deja la profilaxis termina, décadas después, con una estenosis mitral, fibrilación auricular y un accidente cerebrovascular. El médico general debe conocer los criterios de Jones, dar el tratamiento y los plazos de la profilaxis, y reconocer por el examen físico la estenosis mitral, que es de las valvulopatías más preguntadas en el EUNACOM, casi siempre como una mujer con fibrilación auricular, disnea y un retumbo diastólico.

TABLA 4.4.B · FIEBRE REUMÁTICA: TRATAMIENTO Y PROFILAXIS EN EL ADULTO Y EL NIÑO

OBJETIVO	FÁRMACO Y DOSIS	DURACIÓN O SITUACIÓN
Erradicar el estreptococo	Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 si < 27 kg); alternativa amoxicilina 50 mg/kg/día	Dosis única (amoxicilina 10 días); alérgicos: azitromicina o clindamicina
Artritis y fiebre	Aspirina 80-100 mg/kg/día en 4 dosis (adultos 4-8 g/día) o naproxeno	Hasta resolver síntomas y reactantes; descenso en 4-6 semanas
Carditis moderada o grave	Prednisona 1-2 mg/kg/día	2-4 semanas, con descenso gradual
Insuficiencia cardíaca por carditis	Reposo, diuréticos, IECA	Digoxina con cautela
Corea de Sydenham	Ácido valproico o carbamazepina; haloperidol en casos graves	Semanas a meses; la aspirina no la modifica
Prevención secundaria	Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 3-4 semanas	Sin carditis 5 años o hasta los 21; con carditis 10 años o hasta los 21; con secuela valvular 10 años o hasta los 40
Estenosis mitral con FA, trombo o embolia	Acenocumarol o warfarina, INR 2,0-3,0	De por vida; anticoagulantes directos no recomendados

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **33, 66** (págs. 12, 16) · solucionario págs. 24, 28.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.5 Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral

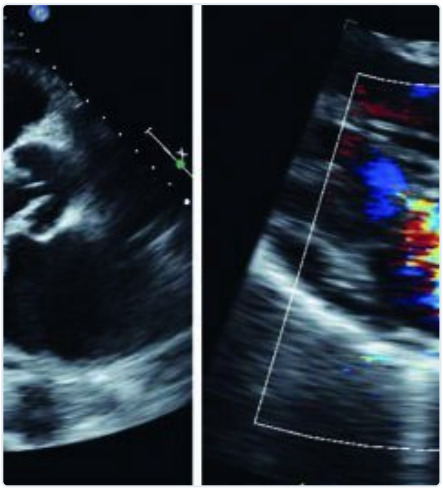
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.019 Insuficiencia mitral

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Insuficiencia mitral clásica**: soplo holosistólico en barra en el ápex, irradiado a la axila y el dorso, con R1 disminuido y R3; no cambia con la inspiración.
- **Primaria (orgánica)**: degenerativa/Barlow, endocarditis, cuerdas rotas, reumática, papilar isquémico. Secundaria (funcional): valvas sanas con miocardiopatía dilatada o isquémica, y se maneja como insuficiencia cardíaca.
- En la insuficiencia mitral primaria severa una FEVI **≤ 60%** ya indica disfunción ventricular, porque el ventrículo eyecta hacia una aurícula de baja presión.
- **Prolapso mitral**: clic mesosistólico + soplo telesistólico; con Valsalva o de pie se adelantan, con cuclillas se retrasan; típico de mujeres jóvenes y Marfan.
- El prolapso sin insuficiencia significativa se tranquiliza; betabloqueador en dosis bajas solo si hay palpitaciones, y no requiere profilaxis de endocarditis.
- **Insuficiencia severa**: volumen regurgitante **≥ 60 mL**, fracción regurgitante **≥ 50%**; cirugía si hay síntomas, FEVI **≤ 60%**, DTSVI **≥ 40 mm**, FA nueva o PSAP > **50 mmHg**.



ECO: PROLAPSO DE BARLOW
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 2042

ALGORITMO · INSUFICIENCIA MITRAL Y PROLAPSO: DEL SOPLO A LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA FRENTE A PROLAPSO VALVULAR MITRAL

PARÁMETRO SEMIOLÓGICO	INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA	PROLAPSO VALVULAR MITRAL (BARLOW)
Temporalidad del soplo	Holosistólico (ocupa toda la sístole)	Telesistólico (final de la sístole) precedido de clic mesosistólico
Irradiación típica	Hacia la axila izquierda y el dorso	Focal en el ápex y el borde esternal
Respuesta a Valsalva o de pie	Disminuye o no varía de duración	El clic se adelanta y el soplo se vuelve más largo
Respuesta a cuclillas	Aumenta de intensidad (poscarga)	El clic se retrasa y el soplo se acorta
R1	Disminuido; R3 frecuente	Normal
Conducta	Plastía mitral reparadora si es severa y cumple criterios	Observación; plastía si hay regurgitación severa

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Holosistólico apical a la axila	Insuficiencia mitral	Insuficiencia tricuspídea
Clic mesosistólico + soplo telesistólico	Prolapso mitral	Insuficiencia mitral clásica
Mujer joven con palpitaciones y prolapso	Eco, tranquilizar, betabloqueador si hay síntomas	Cirugía o profilaxis de endocarditis

REGLA DE ORO **Holosistólico apical, axila, R1 bajo** — No cambia con la inspiración

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **51, 54, 68–69** (págs. 14, 16) · solucionario págs. 26–27, 29.

Clase 4.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

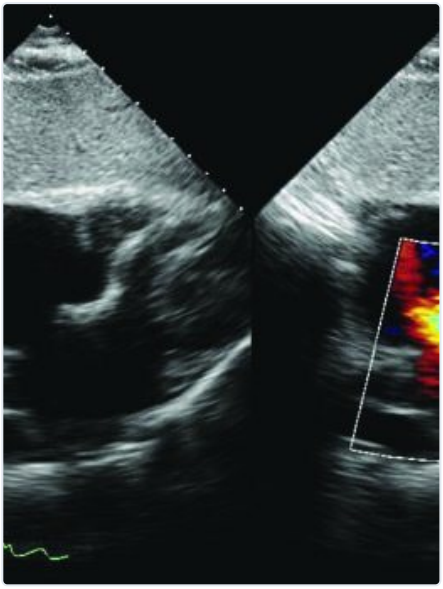
4.6 Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- CIA: desdoblamiento amplio y fijo de R2 que no varía con la respiración, soplo eyectivo pulmonar y bloqueo incompleto de rama derecha (rSR' en V1); es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto.
- La CIA se cierra con dispositivo percutáneo (Amplatzer) si hay sobrecarga del ventrículo derecho o Qp:Qs > 1,5; complicaciones: fibrilación auricular, embolia paradójica, hipertensión pulmonar.
- CIV: soplo holosistólico rudo en barra en el borde esternal izquierdo bajo, con frémito; la pequeña solo se controla y se cierra la que tiene Qp:Qs > 1,5.
- **Ductus**: soplo continuo «en maquinaria» (Gibson) infraclavicular izquierdo con pulso saltón; se cierra con dispositivo o coils; en Eisenmenger hay cianosis diferencial.
- **Coartación**: hipertensión en los brazos, pulsos femorales débiles y retardados, gradiente braquio-femoral > **20 mmHg**, muescas costales de Roesler y signo del 3; se asocia a válvula bicúspide y Turner.
- **Coartación en el adulto**: stent o cirugía; tras la corrección persisten hipertensión y riesgo aórtico; un soplo diastólico tras una coartación operada suele ser insuficiencia aórtica por bicúspide.



ECO: CIA OSTIUM SECUNDUM
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1898

ALGORITMO · CARDIOPATÍA CONGÉNITA DEL ADULTO: DEL HALLAZGO AL DEFECTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

Soplo, arritmia o hipertensión en un joven
Antecedente de soplo infantil

- R2 fijo, soplo pulmonar, rSR' en V1 → **CIA**: Cierre con dispositivo si hay sobrecarga
- Holosistólico con frémito o continuo → **CIV o ductus**: Cierre si Qp:Qs > 1,5
- HTA en brazos, pulsos femorales débiles → **Coartación**: AngioTAC; stent
- Cianosis, hipertensión pulmonar fija → **Eisenmenger**: No cerrar; vasodilatadores

TABLA 4.6 · RESUMEN SEMIOLÓGICO DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CLAVE DEL ADULTO

CARDIOPATÍA CONGÉNITA	HALLAZGO AUSCULTATORIO CARDINAL	SIGNO ELECTROCARDIOGRÁFICO O RADIOLÓGICO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Comunicación interauricular (CIA)	Desdoblamiento amplio y FIJO de R2 + soplo eyectivo pulmonar	ECG: bloqueo incompleto de rama derecha (rSR' en V1) · dilatación AD/VD · botón pulmonar	Cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer (Qp:Qs > 1,5)
Comunicación interventricular (CIV)	Soplo holosistólico rudo en barra + frémito	Cardiomegalia de cavidades izquierdas	Cierre quirúrgico o percutáneo
Ductus arterioso persistente (DAP)	Soplo continuo «en maquinaria» (Gibson) + pulso saltón	Prominencia del botón aórtico y de la arteria pulmonar	Cierre percutáneo con dispositivo o coils
Coartación aórtica	Pulsos femorales disminuidos + HTA en los brazos	Rx: signo de Roesler (muescas costales) y signo del 3	Angioplastía con stent o cirugía resectiva

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DIAGNÓSTICO	ERROR TÍPICO
Holosistólico en barra con frémito	CIV	Ductus o CIA
Operado de coartación con soplo diastólico	Insuficiencia aórtica (bicúspide)	Recoartación
Pies cianóticos, manos rosadas, ductus	Eisenmenger: no cerrar	Cerrar el ductus

REGLA DE ORO — **CIA: R2 fijo + rSR' en V1** — Cierre con Amplatzer si Qp:Qs > 1,5

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **57–64** (págs. 15–16) · solucionario págs. 27–28.

Clase 4.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

4.7 Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.007 **Endocarditis infecciosa y no infecciosa** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Endocarditis bateriana · Profilaxis de endocarditis infecciosa

LO QUE TE PREGUNTAN

- Fiebre + soplo nuevo o cambiante + fenómenos embólicos o inmunológicos = endocarditis hasta demostrar lo contrario.
- **Tres hemocultivos de sitios distintos ANTES del antibiótico**: es el examen de elección para el diagnóstico etiológico; el ecocardiograma muestra la vegetación.
- **Duke**: definida con 2 mayores, o 1 mayor + 3 menores, o 5 menores. Mayores: hemocultivos típicos y evidencia ecocardiográfica.
- **S. viridans** = subaguda sobre válvula dañada (penicilina **4 semanas**; prótesis 6). S. aureus = aguda, usuario de drogas, tricúspide (cloxacilina).
- Cirugía por insuficiencia cardíaca, infección no controlada, embolias con vegetación grande o germen resistente.



MANCHA DE ROTH
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 262

ALGORITMO · ENDOCARDITIS INFECCIOSA: DE LA FIEBRE CON SOPLO A LA CIRUGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

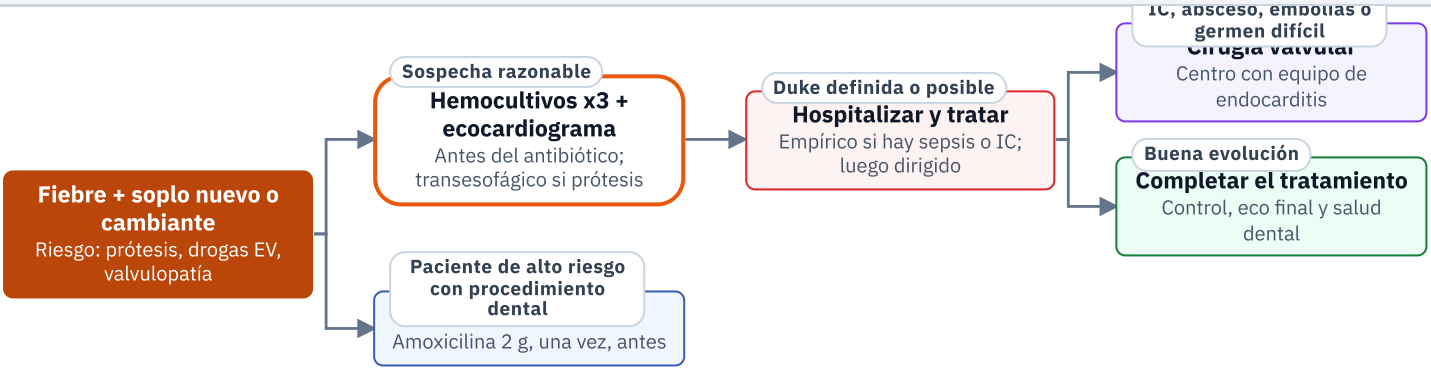


TABLA 4.7 · CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS: MAYORES Y MENORES

TIPO	CRITERIO	CLAVE DE EXAMEN
Mayor	Hemocultivos positivos para germen típico en ≥ 2 muestras separadas (o persistentes)	S. viridans, S. gallolyticus, HACEK, S. aureus, enterococo comunitario
Mayor	Compromiso endocárdico: vegetación, absceso, dehiscencia protésica o regurgitación nueva	Ecocardiograma transtorácico a todos; transesofágico si prótesis o duda
Menor	Predisposición (cardiopatía de riesgo, drogas endovenosas) y fiebre ≥ 38 °C	Prótesis, EI previa, congénita, usuario de drogas
Menor	Fenómenos vasculares: embolias, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, Janeway	Indoloros: Janeway
Menor	Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, Osler, Roth, factor reumatoideo	Dolorosos: Osler · retina: Roth
Diagnóstico	Definida: 2 mayores, o 1 mayor + 3 menores, o 5 menores	Posible: 1 mayor + 1 menor, o 3 menores

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Fiebre prolongada + soplo nuevo	Hemocultivos x3 y ecocardiograma	Antibiótico empírico sin cultivos
Subaguda con germen en cadena	Penicilina o ceftriaxona	Cloxacilina
Prótesis con menos de 2 meses	Estafilococo: vancomicina + gentamicina + rifampicina	Streptococcus viridans

REGLA DE ORO **Fiebre + soplo nuevo o cambiante** — Tres hemocultivos ANTES del antibiótico; eco

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **39–42** (págs. 12–13) · solucionario pág. 25.

Clase 4.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.1 Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación

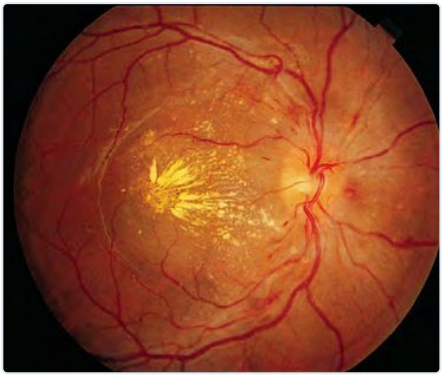
★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.015 **Hipertensión arterial esencial** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Holter de presión arterial

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diagnóstico de HTA**: promedio de **≥ 2 tomas** en **≥ 2 visitas** separadas por **1-2 semanas** con PA **≥ 140/90 mmHg** (perfil de PA).
- Se diagnostica en la primera consulta si PA **≥ 180/**110 o si PA **≥ 140/**90 con daño de órgano blanco.
- **Cortes fuera de la consulta**: MAPA **24 h ≥ 130/**80, diurno **≥ 135/**85, nocturno **≥ 120/**70; AMPA de **7 días ≥ 135/**85.
- **Bata blanca**: consulta alta y MAPA normal (sin fármaco, control anual). Enmascarada: consulta normal y MAPA alto (se trata).
- **MAPA**: dipper (cae **10-20%**), non-dipper (< **10%**), riser (sube de noche): buscar SAHOS, ERC, hiperaldosteronismo.



RETINOPATÍA HIPERTENSIVA
Bates, Guide to Physical Examination and History Taking (2017), Tabla 7-16

ALGORITMO · HIPERTENSIÓN ARTERIAL: DE LA PRESIÓN ALTA AL DIAGNÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

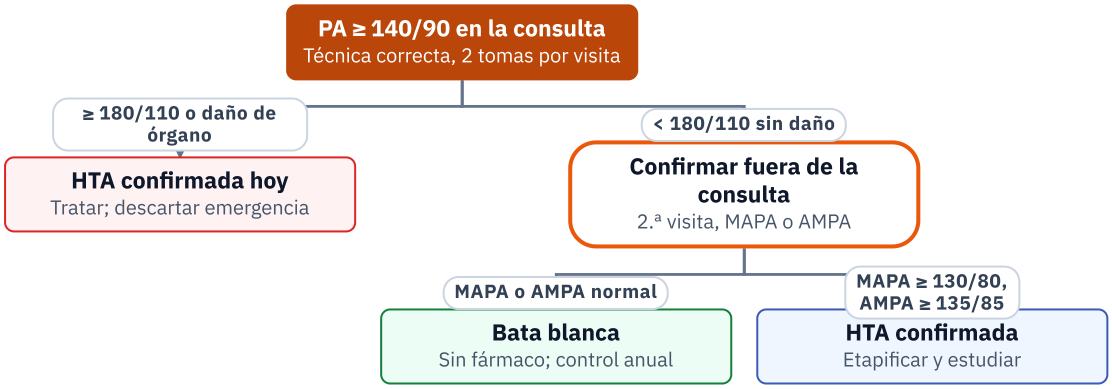


TABLA 5.1 · CRITERIOS DE HIPERTENSIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN POR GRADOS

MÉTODO	SE CONSIDERA HTA SI...	OBSERVACIÓN
Consulta (perfil de PA)	≥ 140/90 mmHg en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas	Promedio de 2 tomas por visita
Primera consulta	≥ 180/110, o ≥ 140/90 con daño de órgano blanco	No se espera una segunda visita
MAPA 24 h	Promedio 24 h ≥ 130/80 · diurno ≥ 135/85 · nocturno ≥ 120/70	Estándar de oro; válido con ≥ 70% de lecturas
AMPA 7 días	Promedio ≥ 135/85 mmHg	2 tomas mañana y 2 noche; se descarta el 1.er día
Grado 1	140-159 / 90-99 mmHg	Riesgo según factores asociados
Grado 2	160-179 / 100-109 mmHg	Mayor probabilidad de requerir 2 fármacos
Grado 3	≥ 180 / 110 mmHg	Descartar daño agudo de órgano blanco
Bata blanca	Consulta ≥ 140/90 y MAPA/AMPA normales	Sin fármacos; control anual
Enmascarada	Consulta normal y MAPA/AMPA elevados	Se trata como HTA

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Consulta ≥ 140/90 en 2 visitas	HTA confirmada	Exigir un MAPA siempre
Descenso nocturno < 10%	Non-dipper: buscar SAHOS, ERC	Ignorarlo
Diabético con 2 tomas ≥ 140/90	Iniciar tratamiento (IECA o ARA II)	Pedir MAPA antes de tratar

REGLA DE ORO — **≥ 140/90 en 2 visitas** — ≥ 180/110 o daño de órgano blanco: una visita

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **73–74, 76** (pág. 17) · solucionario págs. 29–30.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.2 Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.015 Hipertensión arterial esencial — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo hipertenso recibe medidas de estilo de vida; el grado 1 de bajo riesgo las prueba **3-6 meses** antes de agregar fármacos.
- **Primera línea**: IECA o ARA II + calcioantagonista dihidropiridínico o tiazida (dosis fija si PA **≥ 160**/100 o riesgo alto).
- **Diabético o proteinuria**: IECA o ARA II. IECA y ARA II no se combinan y están prohibidos en el embarazo.
- **Tos con IECA**: cambiar a ARA II. Edema maleolar con amlodipino: suspender el amlodipino (no subir el diurético).
- **Metas**: < 130/80 en diabéticos, coronarios, ERC y ACV; 130-139 de PAS a los **65-79 años**; < 150/90 si **≥ 80 años** o frágil.

ALGORITMO · TRATAMIENTO DE LA HTA: DEL DIAGNÓSTICO A LA META

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

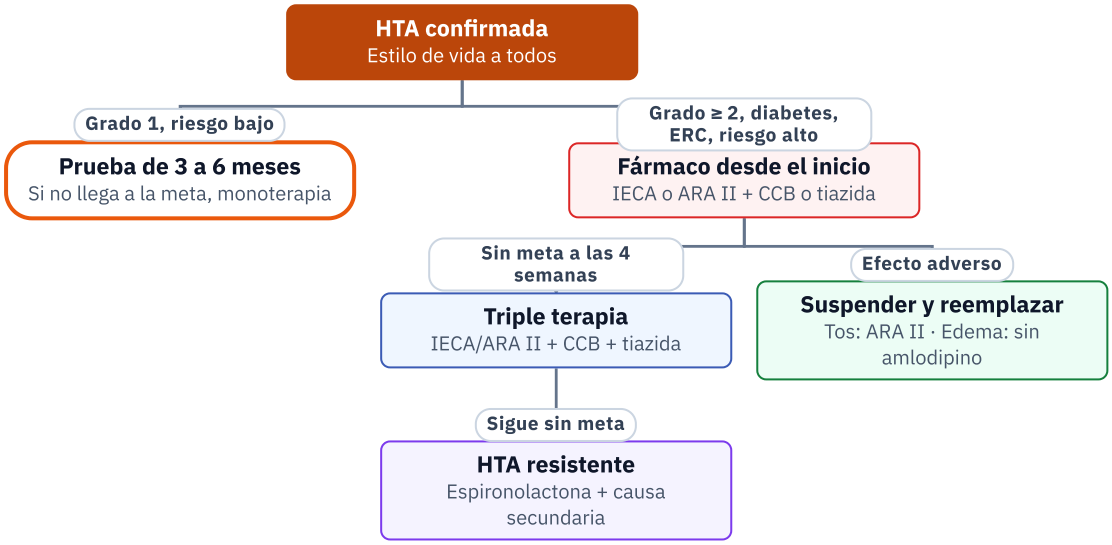


TABLA 5.2 · CLASES DE ANTIHIPERTENSIVOS: EFECTO ADVERSO CARACTERÍSTICO Y CONDUCTA

CLASE (EJEMPLO)	EFECTO ADVERSO CARACTERÍSTICO	CONDUCTA / CONTRAINDICACIÓN
IECA (enalapril)	Tos seca (10-15%), hiperpotasemia, angioedema, alza de creatinina	Tos → cambiar a ARA II; prohibido en embarazo; no combinar con ARA II
ARA II (losartán)	Hiperpotasemia, alza de creatinina; no da tos	Prohibido en embarazo; cuidado en estenosis renal bilateral
Calcioantagonista DHP (amlodipino)	Edema maleolar bilateral, cefalea, rubor	Suspender y reemplazar; el diurético no corrige el edema
Tiazida (hidroclorotiazida)	Hipopotasemia, hiponatremia, hiperuricemia, hiperglicemia	Evitar en gota; ineficaz con VFG < 30 (excepto clortalidona)
Betabloqueador (atenolol, carvedilol)	Bradicardia, broncoespasmo, fatiga, enmascara hipoglicemia	Solo con indicación propia; contraindicado en asma y bloqueo AV
Alfabloqueador (doxazosina)	Hipotensión ortostática en la primera dosis	Fármaco adicional; útil si hay hiperplasia prostática
Espironolactona	Hiperpotasemia, ginecomastia	4.º fármaco de la HTA resistente; controlar potasio y creatinina

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Diabético con proteinuria	IECA (enalapril)	Amlodipino o atenolol de partida
Tos seca con enalapril	Cambiar a ARA II	Agregar otro fármaco o suspender sin reemplazo
Edema bimaleolar con amlodipino	Suspender el amlodipino	Subir el diurético

REGLA DE ORO **IECA o ARA II + CCB o tiazida** — Diabético o proteinuria: IECA

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **75, 77–79** (pág. 17) · solucionario pág. 30.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

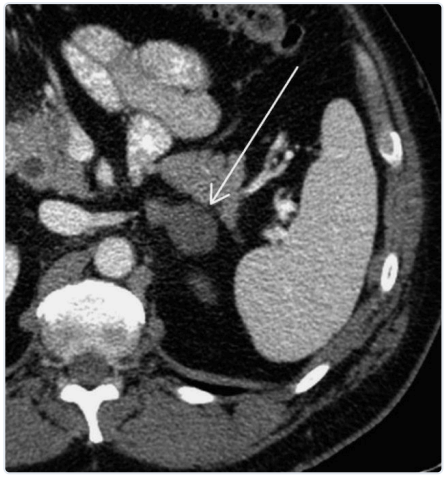
5.3 Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.016 Hipertensión arterial secundaria — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Se sospecha HTA secundaria si hay inicio < **30 años**, HTA grave o resistente a 3 fármacos, daño de órgano blanco desproporcionado o alza de creatinina con IECA.
- **Antes de estudiar**: descartar mala técnica, bata blanca, mala adherencia, exceso de sal y fármacos que suben la PA (AINE, corticoides, ACO).
- **Hipopotasemia espontánea + alcalosis + HTA resistente** → hiperaldosteronismo: tamizaje con ARR > 20-30; solo la mitad tiene potasio bajo.
- Soplo abdominal o creatinina que sube > **30%** tras IECA/ARA II → estenosis de arteria renal: eco-Doppler renal y angioTAC.
- **Cefalea + sudor + palpitaciones paroxísticas** → feocromocitoma: metanefrinas; alfabloqueo antes que betabloqueo, nunca betabloqueador solo.
- **SAHOS**: causa no endocrina más común de HTA resistente (non-dipper): polisomnografía y CPAP.



ADENOMA SUPRARRENAL EN TAC
CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 382

ALGORITMO · HTA SECUNDARIA: DE LA BANDERA ROJA AL EXAMEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

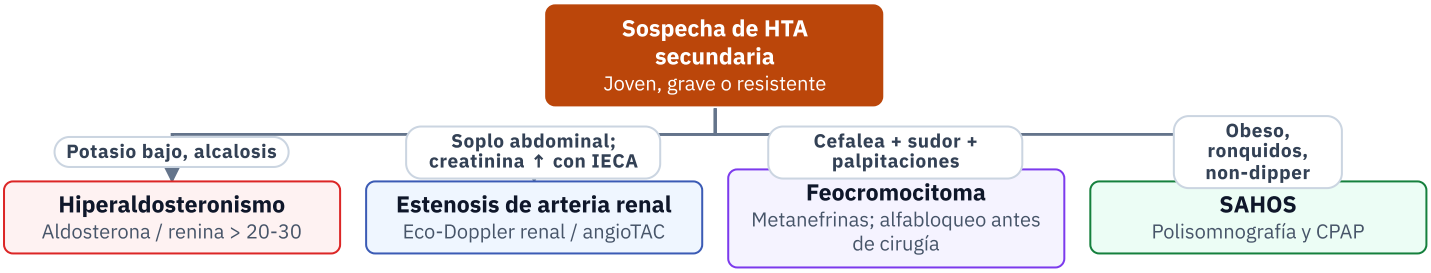


TABLA 5.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE HTA SECUNDARIA

CAUSA	POBLACIÓN Y CUADRO CLÍNICO CLAVE	TAMIZAJE INICIAL	CONDUCTA
Hiperaldosteronismo primario	HTA resistente, hipopotasemia (en 50%), alcalosis	Relación aldosterona/renina (> 20-30)	Adrenalectomía si adenoma; espironolactona
Estenosis de arteria renal	Soplo abdominal; creatinina sube con IECA/ARA II	Eco-Doppler renal; angioTAC	Angioplastía en displasia; médico en ateroesclerosis
Feocromocitoma	Crisis: cefalea + sudor + palpitaciones	Metanefrinas plasmáticas u orina 24 h	Alfabloqueo previo, luego resección
SAHOS	Obeso, ronquidos, somnolencia, non-dipper	Poligrafía / polisomnografía	CPAP y baja de peso
Coartación de la aorta	Joven; pulsos femorales débiles; PA brazos > piernas	Ecocardiograma; angioTAC	Reparación (cirugía o stent)
Enfermedad renal parenquimatosa	Creatinina alta, albuminuria, sedimento activo	Creatinina, RAC, ecografía renal	IECA/ARA II; nefrología
Cushing	Obesidad central, estrías violáceas, glicemia alta	Cortisol libre urinario o supresión con dexametasona	Derivar a endocrinología

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	EXAMEN O CONDUCTA	ERROR TÍPICO
Potasio bajo sin diuréticos	Aldosterona / renina	Metanefrinas o Doppler renal
Triple terapia con PA alta	Espironolactona + estudio	Agregar betabloqueador
Potasio normal con HTA resistente	No descarta Conn	Descartar el hiperaldosteronismo

REGLA DE ORO **Joven, grave, resistente o daño desproporcionado** — Antes: descartar iatrogenia

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, pregunta **50** (pág. 14) · solucionario pág. 26.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.4 Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.09.2.002 Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Crisis hipertensiva**: PAS **≥ 180 y/o** PAD **≥ 120 mmHg**; la gravedad la define el daño agudo de órgano blanco, no la cifra.
- **Urgencia** = sin daño de órgano: reposo, fármaco oral (captopril **25 mg**), descenso gradual y control en APS en **24-48 h**.
- **Emergencia** = con daño agudo: UCI, fármaco EV titulable, PAM ↓ máximo **20-25%** en la 1.ª hora y luego 160/100 en **2-6 h**.
- Un descenso excesivo sobrepasa la autorregulación y causa infarto cerebral o miocárdico iatrogénico.
- **Disección**: PAS < 120 y FC < 60 en < **20 min** con labetalol/esmolol; EAP: nitroglicerina + furosemida; eclampsia: sulfato de magnesio + labetalol.
- **SCA con crisis hipertensiva**: nitroglicerina EV en infusión continua; ACV isquémico: no bajar salvo > 220/120 o trombólisis.



RETINOPATÍA HIPERTENSIVA
Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 263 (Fig. 32-7)

ALGORITMO · CRISIS HIPERTENSIVA: URGENCIA O EMERGENCIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

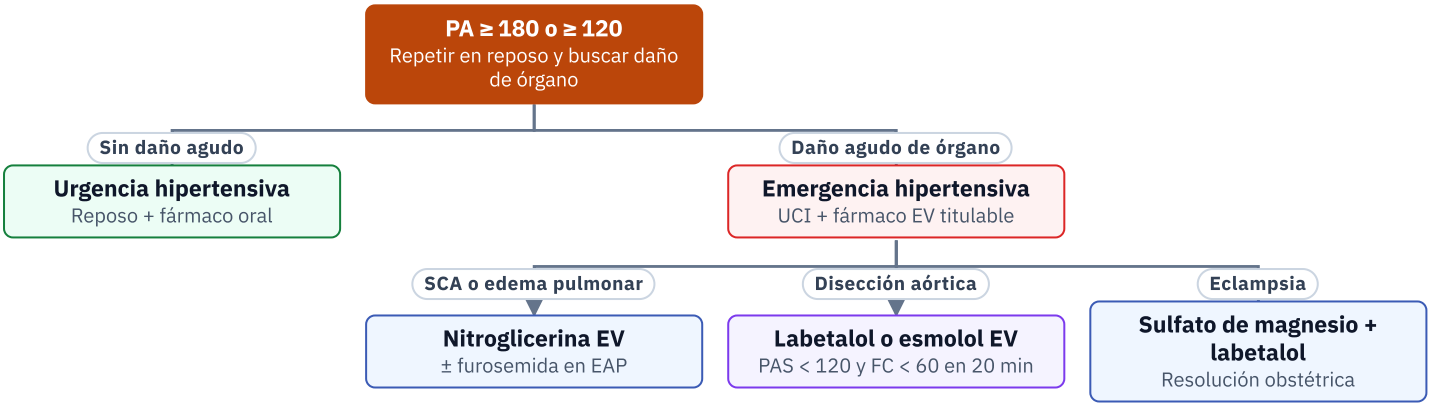


TABLA 5.4 · URGENCIA VERSUS EMERGENCIA HIPERTENSIVA Y FÁRMACO DE ELECCIÓN SEGÚN EL ÓRGANO EN RIESGO

CARACTERÍSTICA / SITUACIÓN	URGENCIA HIPERTENSIVA	EMERGENCIA HIPERTENSIVA
Daño agudo de órgano blanco	Ausente (asintomático o cefalea leve)	Presente y en evolución
Lugar de atención	Box de urgencia / APS	UCI / UTI con monitorización
Vía y fármaco	Oral: captopril 25 mg, labetalol, amlodipino	EV titulable: labetalol, nitroprusiato, nitroglicerina, nicardipino
Meta de descenso	Gradual en 24-48 h; control en APS	PAM ↓ 20-25% en 1 h; 160/100 en 2-6 h
Síndrome coronario agudo	—	Nitroglicerina EV (± betabloqueador)
Edema agudo de pulmón	—	Nitroglicerina EV + furosemida EV
Disección aórtica	—	Labetalol/esmolol EV; PAS < 120 y FC < 60 en < 20 min
Eclampsia / preeclampsia grave	—	Sulfato de magnesio + labetalol o hidralazina
Nifedipino sublingual	Contraindicado	Contraindicado

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
210/115 con cefalea leve y examen normal	Urgencia: reposo, VO, control 24-48 h	UCI y nitroprusiato
ACV isquémico sin trombólisis	No bajar salvo > 220/120	Normalizar la presión
Descenso de PAM > 25% en 1 h	Riesgo de isquemia	Bajar a 120/80 rápido

REGLA DE ORO **Daño agudo de órgano: emergencia** — Sin daño: urgencia

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

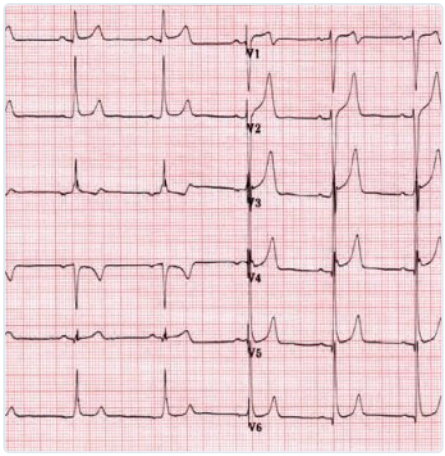
5.5 Pericarditis Aguda

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.022 Pericarditis aguda — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Pericarditis**: **≥ 2 de** 4 criterios (dolor pleurítico que mejora al inclinarse, frote, ECG típico, derrame nuevo).
- ECG: supradesnivel cóncavo y difuso del ST con infradesnivel del PR; sin imagen especular ni ondas Q (salvo aVR y V1).
- Causa idiopática o viral en > **80%** de los casos; se estudia la causa solo si hay alto riesgo.
- **Tratamiento de primera línea**: aspirina **750-1000 mg** c/**8 h** o ibuprofeno **600 mg** c/**8 h** + colchicina **3 meses** + IBP.
- Los corticoides no son de primera línea (aumentan las recurrencias); evitar anticoagulantes.
- Hospitalizar si hay fiebre > **38 °C**, curso subagudo, derrame grande o taponamiento, trauma, anticoagulantes, troponina elevada o falla de AINE.



REPOLARIZACIÓN PRECOZ
Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 191

ALGORITMO · PERICARDITIS AGUDA: DEL DOLOR POSICIONAL AL MANEJO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

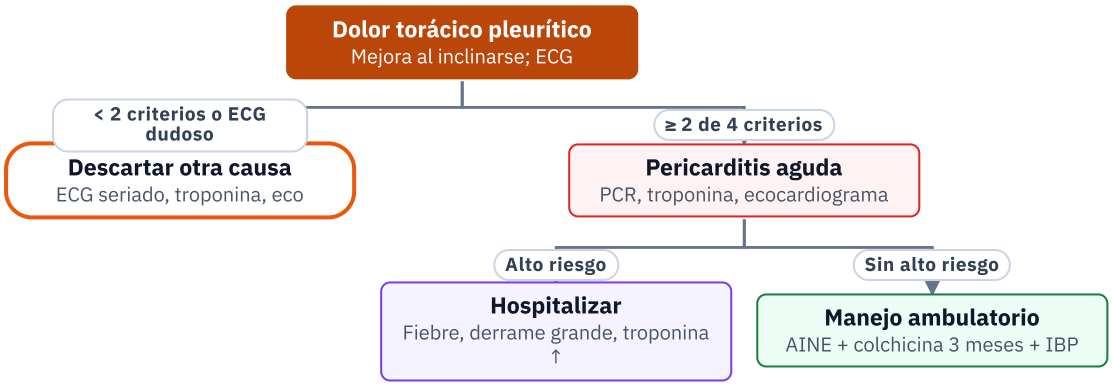


TABLA 5.5 · PERICARDITIS AGUDA FRENTE AL INFARTO CON SUPRADESNIVEL Y AL TAPONAMIENTO

PARÁMETRO	PERICARDITIS AGUDA	INFARTO CON SDST	TAPONAMIENTO
Dolor	Pleurítico; ↓ al inclinarse, ↑ al acostarse	Opresivo, > 20 min, irradiado	Disnea; dolor variable
ST	Cóncavo, difuso, no territorial	Convexo, territorial	Bajo voltaje y alternancia eléctrica
PR e imagen especular	PR descendido; sin imagen especular	Imagen especular; sin cambio del PR	—
Ondas Q	No	Sí (necrosis)	No
Examen	Frote pericárdico	R3, signos de IC	Tríada de Beck, pulso paradojal
Conducta	AINE + colchicina	Reperfusión urgente	Pericardiocentesis

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Joven deportista con ST cóncavo estable	Repolarización precoz	Tratar como pericarditis
Pericarditis + colchicina 3 meses	Previene la recidiva	Solo AINE
Pericarditis posinfarto	Aspirina	Otros AINE

REGLA DE ORO **Dolor posicional, frote, ECG, derrame** — Bastan 2 de 4

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **83–85** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

Clase 5.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.6 Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis

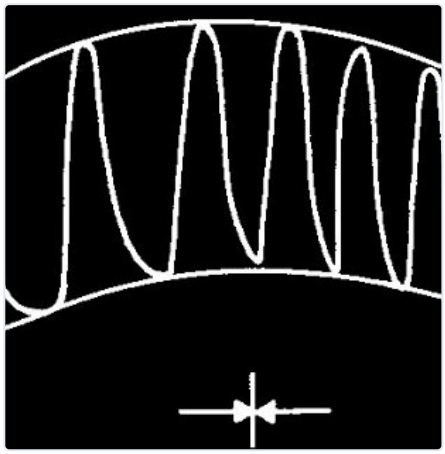
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.008 Taponamiento pericárdico — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Punción pericárdica

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Taponamiento** = shock obstructivo: líquido intrapericárdico a presión que comprime las cavidades derechas en diástole.
- **Tríada de Beck**: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, con pulmones limpios.
- **Pulso paradojal**: caída de la PAS > **10 mmHg** al inspirar (interdependencia ventricular); no confundir con el signo de Kussmaul.
- **ECG: bajo voltaje y alternancia eléctrica; ecocardiograma**: colapso diastólico de AD/VD y VCI dilatada.
- El examen que hace el diagnóstico es el ecocardiograma, que no debe retrasar el drenaje en el paciente inestable.
- **Tratamiento**: pericardiocentesis inmediata (subxifoidea, guiada por eco, con catéter) + volumen EV mientras se prepara.



PULSO PARADOJAL
Bates, Guide to Physical Examination and History Taking (2017), pulso paradójico

ALGORITMO · TAPONAMIENTO CARDÍACO: DEL SHOCK AL DRENAJE

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 5.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PERICARDITIS AGUDA, TAPONAMIENTO Y PERICARDITIS CONSTRICTIVA

PARÁMETRO	PERICARDITIS AGUDA	TAPONAMIENTO CARDÍACO	PERICARDITIS CONSTRICTIVA
Presión arterial	Normal	Hipotensión / shock	Normal o baja
Yugulares	Normales	Ingurgitadas (onda x, sin y)	Ingurgitadas, signo de Kussmaul (↑ en inspiración)
Ruidos cardíacos	Frote pericárdico	Apagados	Knock pericárdico
Pulso	Normal	Paradojal (↓ PAS > 10 al inspirar)	Puede haber paradojal leve
ECG	SDST cóncavo difuso + infra PR	Bajo voltaje + alternancia eléctrica	Inespecífico; FA
Tratamiento	AINE + colchicina	Pericardiocentesis inmediata	Pericardiectomía

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Cáncer de pulmón, síncope, ruidos apagados	Taponamiento	Tromboembolismo pulmonar
Bajo voltaje y alternancia eléctrica	Derrame con taponamiento	Infarto
PAS cae > 10 mmHg al inspirar	Pulso paradojal	Llamarlo signo de Kussmaul

REGLA DE ORO **Tríada de Beck** — Hipotensión, yugulares, ruidos apagados

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **14, 89–90** (págs. 9, 19) · solucionario págs. 22, 31–32.

Clase 5.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.7 Disección Aórtica Aguda

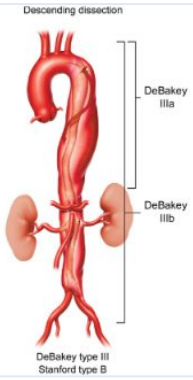
★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

1.01.2.002 Disección aórtica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Angiotac de tórax y aorta

LO QUE TE PREGUNTAN

- Dolor torácico/dorsal súbito, desgarrante y máximo desde el inicio, con diferencia de presión > **20 mmHg** entre brazos o soplo diastólico nuevo.
- **Factor de riesgo principal**: HTA mal controlada; también Marfan, bicúspide, coartación, embarazo, cocaína.
- **Examen de elección**: angioTAC de tórax, abdomen y pelvis; ecocardiograma transesofágico si hay inestabilidad.
- **Stanford A (aorta ascendente)**: cirugía de emergencia. Stanford B (distal a subclavia): tratamiento médico en UCI; TEVAR si hay complicaciones.
- **Meta hemodinámica**: FC < 60 y PAS 100-120 en < **20 min**; betabloqueador EV (labetalol/esmolol) primero y nitroprusiato después.



DISECCIÓN: STANFORD A Y B
Schwartz's Principles of Surgery ABSITE and Board Review, 11.ª ed., Fig. 22-1

ALGORITMO · DISECCIÓN AÓRTICA: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

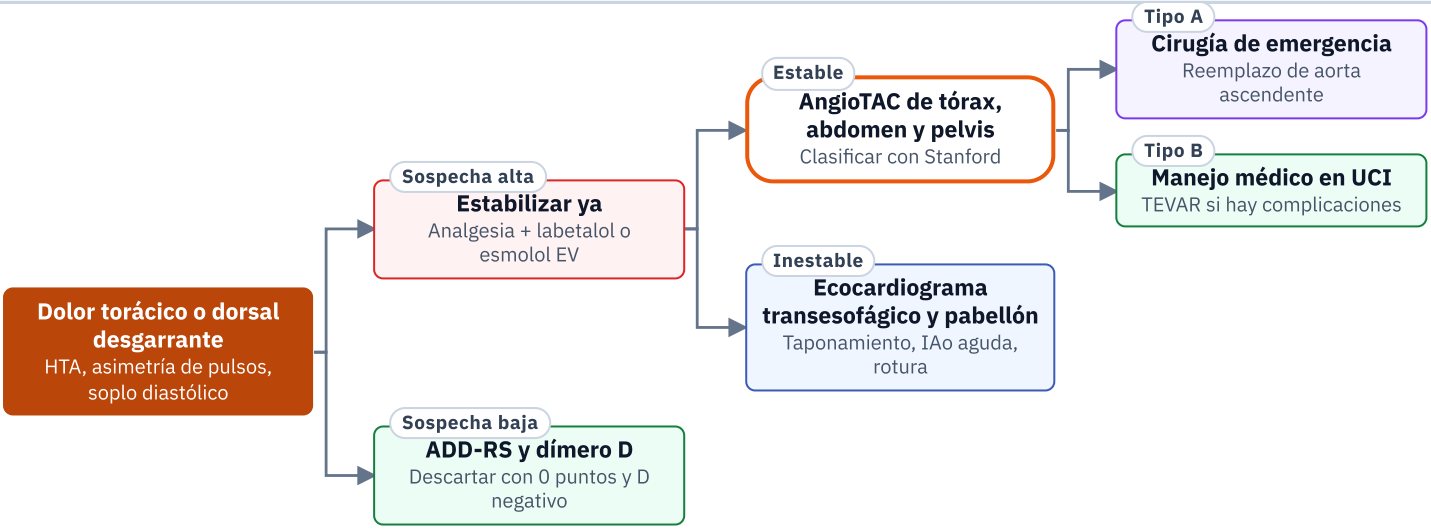


TABLA 5.7 · DOLOR TORÁCICO AGUDO: DISECCIÓN AÓRTICA FRENTE A OTRAS CAUSAS GRAVES

CONDICIÓN	DATO CLÍNICO CARDINAL	EXAMEN DE ELECCIÓN	CONDUCTA
Disección Stanford A	Dolor desgarrante, asimetría de pulsos, soplo de IAo	AngioTAC de tórax, abdomen y pelvis	Betabloqueo EV + cirugía de emergencia
Disección Stanford B	Dolor interescapular migratorio	AngioTAC	Manejo médico en UCI (TEVAR si complicada)
SCACEST	Opresivo, supradesnivel ST, troponina ↑	ECG	Reperfusión (nunca si hay sospecha de disección)
TEP	Disnea, hipoxemia, factor de riesgo	AngioTAC pulmonar	Anticoagulación
Pericarditis	Dolor posicional, frote, ECG difuso	ECG, ecocardiograma	AINE + colchicina
Rotura esofágica	Vómitos previos, enfisema subcutáneo	TAC con contraste oral	Cirugía

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Dolor desgarrante + diferencia de PA entre brazos	Disección: angioTAC	Tratar como infarto
Soplo diastólico nuevo con dolor torácico	Disección tipo A	Rotura de papilar
Tipo A (aorta ascendente)	Cirugía de emergencia	Manejo médico solo

REGLA DE ORO **Dolor desgarrante, máximo al inicio** — Asimetría de PA > 20 mmHg o soplo diastólico

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **30–32, 86** (págs. 11, 18) · solucionario págs. 24, 31.

Clase 5.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.8 Aneurisma de Aorta Abdominal

Alta · Masa pulsátil, ecografía, umbral quirúrgico de 5,5 cm, crecimiento rápido, rotura y su manejo de urgencia

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

4.01.2.022 Aneurisma de aorta abdominal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- AAA: dilatación **≥ 3,0 cm** de la aorta abdominal, infrarrenal en > **90%**; predomina en el varón > **65 años** fumador.
- **Clínica**: casi siempre asintomático; masa pulsátil, expansiva e indolora en epigastrio o mesogastrio.
- **Tamizaje, diagnóstico y seguimiento**: ecografía abdominal (sensibilidad > **95%**); angioTAC para planificar la reparación.
- Se repara si el diámetro es **≥ 5,5 cm** (hombre) o **≥ 5,0 cm** (mujer), crece > **0,5 cm** en **6 meses** (> **1 cm**/año) o es sintomático.
- **Vigilancia**: **3-3,9 cm** cada **3 años**; **4-4,9 cm** cada año; **5-5,4 cm** cada **6 meses**.
- **Rotura**: dolor abdominal o lumbar súbito + masa pulsátil + shock: cirugía de emergencia con hipotensión permisiva.
- **EVAR**: menor mortalidad perioperatoria, pero requiere vigilancia de por vida (endofuga).

ALGORITMO · ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: MEDIR, VIGILAR, REPARAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

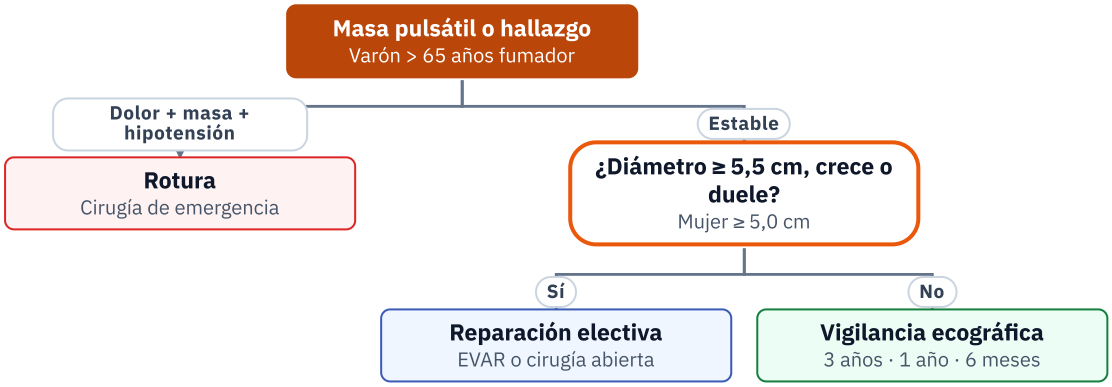


TABLA 5.8 · ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: TAMAÑO, RIESGO DE ROTURA Y CONDUCTA

DIÁMETRO / SITUACIÓN	RIESGO ANUAL DE ROTURA	CONDUCTA
3,0-3,9 cm	Muy bajo (< 0,5%)	Ecografía cada 3 años; control de factores de riesgo
4,0-4,9 cm	0,5-1,5%	Ecografía cada 12 meses
5,0-5,4 cm	1-5%	Ecografía cada 6 meses (reparar si mujer)
≥ 5,5 cm (hombre) / ≥ 5,0 cm (mujer)	5-20%	Reparación electiva: EVAR o cirugía abierta
Crecimiento > 0,5 cm en 6 meses o > 1 cm/año	Alto	Reparación aunque sea < 5,5 cm
Sintomático (dolor lumbar o abdominal)	Rotura inminente	Reparación urgente
Rotura (dolor + masa pulsátil + shock)	—	Cirugía de emergencia; hipotensión permisiva

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Masa pulsátil indolora en un fumador mayor	Ecografía abdominal	TAC sin ecografía o cirugía directa
AAA de 5,8 cm asintomático	Reparar: derivar a cirugía vascular	Control anual o anticoagular
AAA de 4,5 cm estable	Eco cada año	Operar
Crece > 0,5 cm en 6 meses	Reparar	Esperar a 5,5 cm
Dolor desgarrante torácico + asimetría	Disección	Pensar en AAA

REGLA DE ORO **Dilatación ≥ 3 cm, infrarrenal** — Varón > 65 años, fumador

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 5.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

5.9 Tromboembolismo Pulmonar

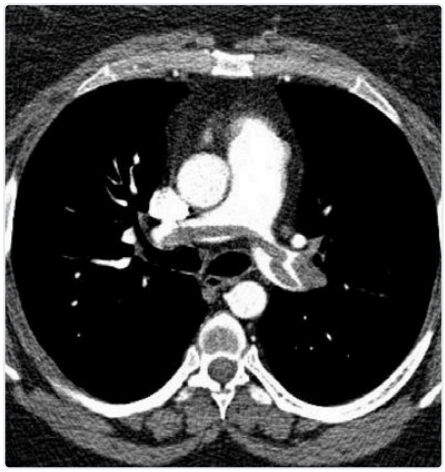
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.01.1.006 **Embolia pulmonar** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Embolia pulmonar masiva · Angiotac de tórax y aorta

LO QUE TE PREGUNTAN

- TEP: > **90%** de origen en las venas profundas proximales de las piernas; la tríada de Virchow explica los factores de riesgo.
- **Probabilidad baja o intermedia (Wells ≤ 4)**: dímero D; si es negativo se descarta, si es positivo se pide angioTAC.
- **Probabilidad alta (Wells > 4)**: no se pide dímero D; se solicita angioTAC de arterias pulmonares directamente.
- Contraindicación del contraste (alergia, VFG < 30) o embarazo: cintigrama V/Q.
- **TEP masivo** = hipotensión o shock por falla del VD: ecocardiograma a la cabecera y fibrinólisis (alteplasa **100 mg** en **2 h**) con heparina.
- **TEP estable**: DOAC (apixabán o rivaroxabán) en monoterapia oral; HBPM en cáncer y embarazo.



ANGIOTAC: ÉMBOLOS
MedSchoolBro Pulmonology, p. 15

ALGORITMO · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: DEL DIAGNÓSTICO A LA TERAPIA SEGÚN EL RIESGO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

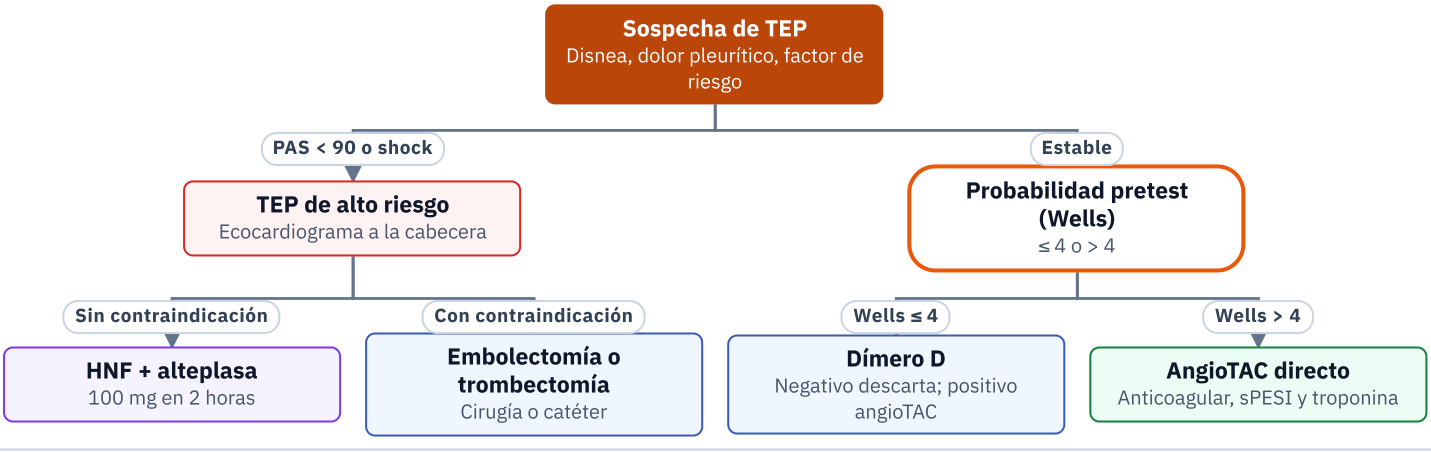


TABLA 5.9 · ESTRATIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO

CATEGORÍA DE RIESGO	HEMODINAMIA	DISFUNCIÓN DE VD / TROPONINA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto riesgo (masivo)	PAS < 90 mmHg, shock o vasopresores	VD dilatado, troponina elevada	HNF + fibrinólisis (alteplasa 100 mg en 2 h); embolectomía si hay contraindicación
Intermedio-alto	Estable; sPESI ≥ 1	Ambos positivos (VD y troponina)	Anticoagulación + monitorización en unidad de cuidados
Intermedio-bajo	Estable; sPESI ≥ 1	Solo uno positivo	Anticoagulación; hospitalización en sala
Bajo riesgo	Estable; sPESI = 0	Negativos	DOAC; alta precoz o manejo ambulatorio

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Wells ≤ 4	Dímero D	AngioTAC directo
Wells > 4	AngioTAC directo	Dímero D
Shock + disnea + ingurgitación yugular	Ecocardiograma; alteplasa si VD dilatado	Esperar el angioTAC

REGLA DE ORO **Wells ≤ 4: dímero D · Wells > 4: angioTAC** — Contraste contraindicado: V/Q

PRACTICA **Libro Gordo Cardiología**, preguntas **37–38** (pág. 12) · solucionario pág. 25.

Clase 5.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

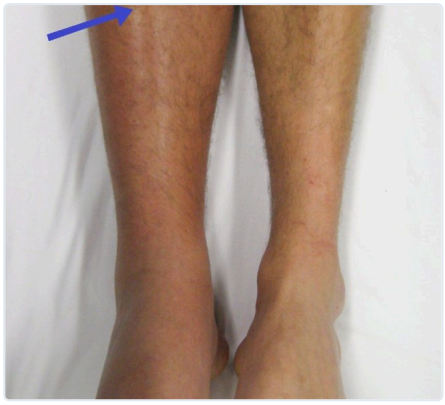
5.10 Trombosis Venosa Profunda

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

4.01.1.049 Trombosis venosa profunda y tromboflebitis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- TVP: dolor, pantorrilla > **3 cm** más gruesa (**10 cm** bajo la tuberosidad tibial), empastamiento y venas colaterales; Homans poco sensible.
- **Wells para TVP**: **≥ 2** «probable» (eco-Doppler directo); < 2 «improbable» (dímero D, y eco si es positivo).
- El dímero D tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo alto: un resultado negativo descarta, uno positivo no confirma.
- **Examen confirmatorio**: eco-Doppler venoso con compresión (vena no colapsable); repetir en **1 semana** si es negativo y la sospecha persiste.
- **Tratamiento**: HBPM o DOAC (rivaroxabán, apixabán) de inmediato; deambulación precoz; **3 meses** si fue provocada.



TVP DE LA PIERNA DERECHA
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

ALGORITMO · TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

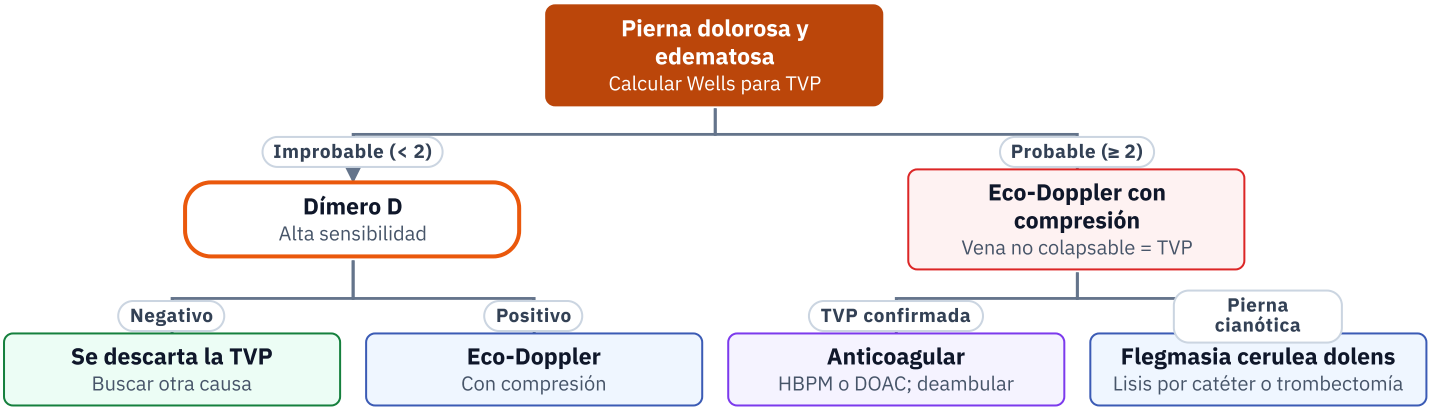


TABLA 5.10 · TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: DATOS CLÍNICOS, EXAMEN Y CONDUCTA

ASPECTO	HALLAZGO O DATO CLAVE	CONDUCTA
Clínica	Pantorrilla > 3 cm, dolor, empastamiento, venas colaterales	Calcular Wells; Homans no sirve
Dímero D	Alta sensibilidad y VPN; baja especificidad	Negativo en probabilidad improbable: descarta TVP
Eco-Doppler con compresión	Vena no colapsable	Confirma; repetir en 1 semana si es negativo y la sospecha persiste
Tratamiento	HBPM o DOAC; deambulación	3 meses (provocada); 3-6 meses o indefinida (no provocada, cáncer, SAF)
Flegmasia cerulea dolens	Pierna cianótica, edema a tensión, pulsos ausentes	Heparina + trombólisis por catéter o trombectomía urgente
Trombofilia / SAF	TVP en < 45 años, TTPA prolongado, VDRL falso positivo	Warfarina; estudio de trombofilia al terminar
Tromboflebitis superficial	Cordón doloroso en vena superficial	AINE; anticoagular si ≥ 5 cm o cerca de la unión safeno-femoral

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Pierna hinchada con alta probabilidad	Eco-Doppler con compresión	Dímero D
TVP confirmada	HBPM o DOAC + deambulación	Reposo absoluto
Joven + TTPA prolongado + VDRL (+)	Síndrome antifosfolípido: warfarina	DOAC o déficit de factor VIII

REGLA DE ORO **Wells: ≥ 2 eco-Doppler · < 2 dímero D** — Dímero D negativo descarta

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cardiología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 5.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 38 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO	
1.1 Lectura Sistemática del Electrocardiograma	pág. 4
Sokolow **≥ 35 mm**: HVI — Hipertenso de alto riesgo	CORTE
1.2 Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático	pág. 5
100-120/min · **≥ 5 cm** · 30:2 — Relevo cada **2 min**	CORTE
100-120 por minuto — **≥ 5 cm** de profundidad (máx. **6 cm**)	CORTE
1.3 ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro	pág. 6
SpO_2 **92-98%** · PAM **≥ 65 mmHg** — Evitar la hiperoxia	CORTE
1.4 Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo	pág. 7
Meta: FC < **110 lpm** en reposo — Control laxo	META
Ablación del istmo cavotricuspídeo — Éxito > **95%**	CORTE
1.5 Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K	pág. 8
Edad **≥ 75 años** — A_2	CORTE
1.6 Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White	pág. 9
Taquicardia sinusal: inicio gradual — < 150-160 y con causa	CORTE
WPW en ritmo sinusal: PR < 120 ms + onda delta + QRS ancho.	CORTE
1.7 Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica	pág. 10
Corregir K > 4 y Mg — ECG de 12 derivaciones, buscar isquemia	DOSIS
Amiodarona **150 mg** EV en **10 min** — Luego **1 mg**/min por **6 horas**	DOSIS
1.8 Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos	pág. 11
PR > 200 ms constante — Benigno, sin marcapaso	CORTE
1.º atropina **1 mg** EV cada **3-5 min** — Máximo **3 mg**	DOSIS
1.9 Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo	pág. 12
FC mínima, media y máxima · pausas — Pausa > 3 s en vigilia: patológica	CORTE
BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA	
2.1 Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar	pág. 13
Basal muy bajo o sin delta — Descarta con VPN > **99%**	CORTE
2.2 Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía	pág. 14
ST **≥ 2 mm**, precoz o caída de PAS — Coronariografía	CORTE
FFR **≤ 0,80** = significativa — 1, 2 o 3 vasos; tronco y DA proximal	CORTE
2.3 Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria	pág. 15
Stent farmacoactivo; SYNTAX **≤ 22** — Trata la lesión culpable	CORTE
Tronco **≥ 50%** o 3 vasos — Diabético o FEVI baja; SYNTAX **≥ 33**	CORTE
2.4 SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel	pág. 16
GRACE > 140: alto riesgo isquémico — < 109 bajo riesgo	CORTE
2.5 SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES	pág. 17
Atorvastatina **80 mg** — LDL < **55 mg/dL**	DOSIS
Todas las derivaciones: **≥ 1 mm** — Salvo V2 y V3	CORTE
2.6 Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal	pág. 18
Colapso, AESP y taponamiento — Mortalidad > **90%**	CORTE
FV y TV: principal muerte prehospitalaria — Desfibrilar; K > 4, Mg > 2	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO	
3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos	pág. 19
FEr: FEVI **≤ 40%** — Falla la contracción	CORTE
Pesarse a diario — Consultar si sube > **2 kg** en **3 días**	CORTE
3.2 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos	pág. 20
K < 5,0 y VFG > 30 — Antes de iniciar	CORTE
Ivabradina — Sinusal, FC **≥ 70, FEVI ≤ 35%**	CORTE
3.3 Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón	pág. 21
O_2 solo si $SatO_2$ < **90%** — Meta **94-98%**	META
3.4 Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks	pág. 22
Confusión, oliguria < **0,5 mL/kg**/h — PAS < 90 o PAM < 65	DOSIS
3.5 Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven	pág. 23
Atleta, HTA, estenosis aórtica, amiloidosis — El atleta: septo < **13-15 mm**	DOSIS
ECG con HVI y Q; eco con septo **≥ 15 mm** — Estudiar a la familia	CORTE
3.6 Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis	pág. 24
Alcohol > **80 g**/día por > **5 años** — Reversible con abstinencia	DOSIS
Último mes de embarazo a **5 meses** del parto — FEVI < **45%**	CORTE
BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS	
4.2 Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular	pág. 27
Área valvular **≤ 1,0 cm²** — Indexada < **0,6 cm²**/m²	CORTE
FEVI < **50%**, esfuerzo anormal — O cirugía cardíaca por otra causa	CORTE
4.3 Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica	pág. 28
Vasodilatadores: IECA, nifedipino — Meta < 130/**80 mmHg**	META
Vol. regurgitante **≥ 60 mL** — Fracción regurgitante **≥ 50%**	DOSIS
4.4 Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática	pág. 29
VSG o PCR elevadas · PR largo — VHS **≥ 60 o** PCR **≥ 3 mg/dL**	DOSIS
Área mitral **≤ 1,5 cm²** — PSAP > **50 mmHg** = repercusión	CORTE
4.5 Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral	pág. 31
Vol. regurgitante **≥ 60 mL** — Fracción **≥ 50%**; vena contracta **≥ 7 mm**	DOSIS
4.6 Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación	pág. 32
CIA: R2 fijo + rSR' en V1 — Cierre con Amplatzer si Qp:Qs > 1,5	CORTE
Embarazo contraindicado — Mortalidad materna de **30 a 50%**	CORTE
4.7 Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis	pág. 33
Prevenir embolias — Vegetación > **10 mm** con embolia, o > **15 mm**	CORTE
Predisposición y fiebre **≥ 38** °C — Prótesis, drogas EV, cardiopatía	CORTE
BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR	
5.1 Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación	pág. 34
MAPA **24 h ≥ 130**/80 — Día **≥ 135**/85 · noche **≥ 120**/70	CORTE
≥ 140/90 en **≥ 2 visitas** — Separadas por **1-2 semanas**	CORTE
5.2 Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES	pág. 35
≥ 80 años o frágil: < 150/90 — **85 años** con 145/75: mantener	META
65-79 años: PAS 130-139 — PAD < 80 si lo tolera	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.3 Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla	pág. 36
Aldosterona / renina > 20-30 — Luego TAC de suprarrenales	CORTE
Creatinina ↑ > **30%** tras IECA — Soplo sistodiastólico abdominal	CORTE
5.4 Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva	pág. 37
Disección: labetalol o esmolol — PAS < 120 y FC < 60 en < **20 min**	CORTE
5.5 Pericarditis Aguda	pág. 38
Colchicina **3 meses** — **0,5 mg**/día si < **70 kg**; **0,5 mg** c/**12 h** si **≥ 70 kg**	DOSIS
Recurrencia **15-30%** — Taponamiento: Tema 5.6	CORTE
5.6 Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis	pág. 39
PAS cae > **10 mmHg** al inspirar — Interdependencia ventricular	CORTE
5.7 Disección Aórtica Aguda	pág. 40
Rx de tórax: mediastino > **8 cm** — Normal no descarta	CORTE
Analgesia + labetalol o esmolol EV — FC < 60 y PAS 100-120 en < **20 min**	CORTE
5.8 Aneurisma de Aorta Abdominal	pág. 41
Crece > **0,5 cm** en **6 meses** — O > **1 cm** al año	CORTE
5.9 Tromboembolismo Pulmonar	pág. 42
PAS < 90 o shock — Mortalidad > **15-30%**	CORTE
5.10 Trombosis Venosa Profunda	pág. 43
Enoxaparina **1 mg/kg** c/**12 h** — HNF si IRC grave	DOSIS

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.3 ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro		pág. 6
FV y TV sin pulso · Antiarrítmicos	**Tras la 3.ª descarga: amiodarona 300 mg**	Luego **150 mg**
1.4 Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo		pág. 7
Qué fármaco, y cuál no · Para frenar el nodo AV	**Metoprolol, bisoprolol, carvedilol**	Primera línea con FEVI conservada
Qué fármaco, y cuál no · Para frenar el nodo AV	**Digoxina**	Insuficiencia cardíaca o sedentario
1.5 Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K		pág. 8
ACOD · Anticoagulantes orales directos	**Apixabán 5 mg c/12 h**	**2,5 mg** si 2 de: **≥ 80 años**, **≤ 60 kg**, creatinina **≥ 1,5**
ACOD · Anticoagulantes orales directos	**Rivaroxabán 20 mg/día con comida · dabigatrán 150 mg c/12 h**	Edoxabán **60 mg**/día
FA valvular · Qué se da	**IRC grave: antagonista de vitamina K o apixabán**	No heparina de bajo peso
1.7 Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica		pág. 10
Qué se da y qué viene después · TV monomorfa estable	**Amiodarona 150 mg EV en 10 min**	Luego **1 mg**/min por **6 horas**
2.3 Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria		pág. 15
Antiagregar y bajar el LDL	**Aspirina 100 mg al día, de por vida**	Clopidogrel **75 mg** si no la tolera
Antiagregar y bajar el LDL	**Atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40**	Meta LDL < 55 y reducción **≥ 50%**
Para los síntomas · Primera línea	**Bisoprolol 5-10 mg · atenolol · metoprolol**	Cardioselectivos; FC de reposo 55-60
2.4 SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel		pág. 16
Antiagregar, anticoagular y aliviar · Doble antiagregación	**Aspirina 250-500 mg masticada**	Luego **100 mg** al día de por vida
Antiagregar, anticoagular y aliviar · Doble antiagregación	**Clopidogrel 300-600 mg si no se puede**	
Antiagregar, anticoagular y aliviar · Anticoagulación	**Enoxaparina 1 mg/kg c/12 h**	c/**24 h** si VFG < 30; HNF si ACTP inmediata
2.5 SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES		pág. 17
Antiagregar y anticoagular	**Aspirina 250 mg masticada**	Luego **100 mg**/día de por vida
Antiagregar y anticoagular	**Fibrinólisis: clopidogrel 300 mg**	**≥ 75 años**: **75 mg** sin carga; + enoxaparina
Las metas de tiempo y el alta · Al alta	**Aspirina + P2Y12 por 12 meses**	Doble antiagregación
Las metas de tiempo y el alta · Al alta	**Atorvastatina 80 mg**	LDL < **55 mg/dL**
3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos		pág. 19
Qué hace el médico general · El mismo día	**Furosemida 20-40 mg al día**	Hasta el peso seco
Qué hace el médico general · El mismo día	**AINE, nifedipino, verapamilo**	
3.2 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos		pág. 20
IECA, ARA II o ARNI · IECA y ARA II	**Enalapril 2,5 mg c/12 h → 10-20 mg**	Captopril, lisinopril
IECA, ARA II o ARNI · IECA y ARA II	**Losartán, candesartán**	
Betabloqueadores con evidencia · Cuáles	**Bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato**	No atenolol ni propranolol

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
5.10 Trombosis Venosa Profunda (cont.)		pág. 43
Betabloqueadores con evidencia · Cuáles	**Bisoprolol 1,25 → 10 mg; carvedilol 3,125 → 25 mg c/12 h**	Metoprolol succ. 12,5-25 → **200 mg**
3.3 Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón		pág. 21
Alta y prevención de reingresos · Antes del alta	**Diurético oral y peso seco**	Pérdida de **0,5-1 kg** al día
Alta y prevención de reingresos · Antes del alta	**IECA/ARNI, BB, espironolactona, iSGLT2**	
3.5 Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven		pág. 23
Qué dar y cuándo operar · Medidas y fármacos	**Betabloqueador: bisoprolol, propranolol**	Alarga la diástole, baja el gradiente
3.6 Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis		pág. 24
Disnea en el puerperio · Según embarazo o lactancia	**Embarazada: hidralazina, nitrato, BB, diurético**	Sin IECA, ARA II ni espironolactona
Cuidado	**Diuréticos con cuidado; sin digoxina ni betabloqueador**	La precarga es indispensable
Soporte y reposo	**Soporte; IECA y betabloqueador al estabilizar**	Sin corticoides de rutina ni AINE
4.4 Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática		pág. 29
Cuatro pilares · Erradicar y antiinflamar	**Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM**	Dosis única; 600.000 si < **27 kg**
Cuatro pilares · Erradicar y antiinflamar	**Aspirina 80-100 mg/kg/día**	Para la artritis y la fiebre
Siempre · Control de frecuencia	**Betabloqueador, verapamilo o digoxina en FA**	
Siempre	**Acenocumarol o warfarina, INR 2 a 3**	Si hay FA, trombo o embolia previa
4.7 Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis		pág. 33
Hospitalizar, cultivar y tratar · Conducta inicial	**Nativa: ampicilina + cloxacilina + gentamicina**	Prótesis o SARM: vancomicina + gentamicina
Esquema	**Amoxicilina 2 g VO, 30-60 min antes**	Una sola dosis; no se repite
Esquema	**Alérgico: azitromicina o claritromicina 500 mg**	Doxiciclina **100 mg**; la clindamicina ya no
5.2 Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES		pág. 35
Calcioantagonista DHP	**Verapamilo y diltiazem frenan el nodo AV**	No combinar con betabloqueador
Tiazidas y otros	**Espironolactona: hiperpotasemia**	Betabloqueador: solo con indicación propia
5.3 Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla		pág. 36
Síndrome de Conn · Estudio y tratamiento	**Hiperplasia: espironolactona**	
5.4 Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva		pág. 37
Qué usar según el órgano · Corazón	**SCA: nitroglicerina EV**	En infusión continua
Qué usar según el órgano · Corazón	**EAP: nitroglicerina + furosemida**	Baja precarga y poscarga
Qué usar según el órgano · Corazón	**Disección: labetalol o esmolol**	PAS < 120 y FC < 60 en < **20 min**
Qué usar según el órgano · Cerebro, embarazo y otros	**Encefalopatía: labetalol, nicardipino**	ACV isquémico: no bajar salvo > 220/120
5.5 Pericarditis Aguda		pág. 38
Antiinflamatorio más colchicina · Primera línea	**Aspirina 750-1000 mg o ibuprofeno 600 mg c/8 h**	**1-2 semanas**, con IBP
5.7 Disección Aórtica Aguda		pág. 40
Estabilizar y luego definir · Inicial	**Analgesia + labetalol o esmolol EV**	FC < 60 y PAS 100-120 en < **20 min**

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
5.9 Tromboembolismo Pulmonar		pág. 42
Fibrinólisis y anticoagulación · TEP masivo	**Heparina no fraccionada + alteplasa**	**100 mg** en **2 h**; **0,6 mg/kg** en paro
Fibrinólisis y anticoagulación · TEP estable	**Apixabán 10 mg c/12 h por 7 días, luego 5 mg**	Rivaroxabán **15 mg** c/**12 h** por **21 días**, luego **20 mg**
Fibrinólisis y anticoagulación · TEP estable	**Warfarina en SAF e IRC grave**	
5.10 Trombosis Venosa Profunda		pág. 43
Anticoagular de inmediato · Primera línea	**Rivaroxabán 15 mg c/12 h × 21 días; apixabán 10 mg c/12 h × 7 días**	Sin heparina previa; luego dosis de mantención

GES de Cardiología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Implante de marcapaso en el bloqueo AV de alto grado y en la enfermedad del nodo sinusal sintomática (problema de salud GES)**

Tema **1.8** · Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos
`1.01.1.002` · `1.01.2.009`
pág. **11**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.° 5): Infarto Agudo del Miocardio (el ECG ante la sospecha es parte de la garantía)**

Tema **2.1** · Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar
`1.01.4.007` · `1.01.4.009`
pág. **13**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.° 5): Infarto Agudo del Miocardio**

Tema **2.4** · SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel
`1.01.2.001` · `1.01.4.009`
pág. **16**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.° 5): Infarto Agudo del Miocardio**

Tema **2.5** · SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES
`1.01.2.004` · `1.01.5.009` · `1.01.4.007`
pág. **17**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.° 5): Infarto Agudo del Miocardio (la angina de Prinzmetal no es GES)**

Tema **2.6** · Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal
`1.01.2.004` · `1.01.4.006`
pág. **18**

GES **Las cardiopatías congénitas operables y la cirugía de las válvulas tienen garantía GES (se revisan en los temas siguientes)**

Tema **4.1** · Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas
`1.01.1.021`
pág. **26**

GES **Garantía GES de cirugía de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide (lesiones crónicas) en personas de 15 años y más**

Tema **4.2** · Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular
`1.01.1.009` · `1.01.4.006`
pág. **27**

GES **Garantía GES de cirugía de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide (lesiones crónicas) en personas de 15 años y más**

Tema **4.3** · Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica
`1.01.1.017`
pág. **28**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía GES de cirugía de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide (lesiones crónicas) en personas de 15 años y más**

Tema **4.5** · Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral
1.01.1.019
pág. **31**

GES **Garantía GES para las cardiopatías congénitas operables en menores de 15 años; el adulto con un defecto no corregido o residual se deriva a cardiología especializada**

Tema **4.6** · Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación
1.01.1.003
pág. **32**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.º 21): Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años y más**

Tema **5.1** · Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación
1.01.1.015 · 1.01.4.011
pág. **34**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.º 21): Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años y más**

Tema **5.2** · Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES
1.01.1.015
pág. **35**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N.º 21): Hipertensión Arterial Primaria o Esencial (la HTA secundaria queda fuera de la garantía hasta descartar la causa)**

Tema **5.3** · Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla
1.01.1.016
pág. **36**

GES **La crisis hipertensiva no es un problema GES en sí; la HTA de base sí lo es (GES N.º 21)**

Tema **5.4** · Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva
1.09.2.002
pág. **37**

Sin garantía GES específica (24 temas): 1.1 · 1.2 · 1.3 · 1.4 · 1.5 · 1.6 · 1.7 · 1.9 · 2.2 · 2.3 · 3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4 · 3.5 · 3.6 · 4.4 · 4.7 · 5.5 · 5.6 · 5.7 · 5.8 · 5.9 · 5.10. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

7 temas · ★★★

- ★★★ **2.6** Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal — 18
- ★★★ **5.1** Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación — 34
- ★★★ **5.2** Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES — 35
- ★★★ **2.5** SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES — 17
- ★★★ **3.1** Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos — 19
- ★★★ **1.4** Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo — 7
- ★★★ **3.2** Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos — 20

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 6–10, 46, 48, 53, 71–79.

DÍA 2

7 temas · ★★★

- ★★★ **4.6** Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación — 32
- ★★★ **5.7** Disección Aórtica Aguda — 40
- ★★★ **4.2** Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular — 27
- ★★★ **2.2** Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía — 14
- ★★★ **1.6** Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White — 9
- ★★★ **1.7** Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica — 10
- ★★★ **2.3** Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria — 15

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 1–2, 11–13, 18–25, 30–32, 34–36, 57–64, 86–88.

DÍA 3

6 temas · ★★

- ★★☆ **4.7** Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis — 33
- ★★☆ **1.8** Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos — 11
- ★★☆ **3.5** Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven — 23
- ★★☆ **3.6** Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis — 24
- ★★☆ **5.5** Pericarditis Aguda — 38
- ★★☆ **1.2** Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático — 5

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 3–5, 15–17, 26, 39–42, 55–56, 80–81, 83–85.

DÍA 4

6 temas · ★★

- ★★☆ **4.3** Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica — 28
- ★★☆ **5.3** Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla — 36
- ★★☆ **4.4** Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática — 29
- ★★☆ **4.5** Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral — 31
- ★★☆ **5.6** Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis — 39
- ★★☆ **1.1** Lectura Sistemática del Electrocardiograma — 4

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 14, 33, 50–52, 54, 66, 68–69, 89–90.

DÍA 5

6 temas · ★★

- ★★☆ **2.1** Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar — 13
- ★★☆ **2.4** SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel — 16
- ★★☆ **3.3** Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón — 21
- ★★☆ **5.8** Aneurisma de Aorta Abdominal — 41
- ★★☆ **5.9** Tromboembolismo Pulmonar — 42
- ★☆☆ **1.3** ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro — 6

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 27–29, 37–38, 47, 49.

DÍA 6

6 temas · ★

- ★☆☆ **1.5** Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K — 8
- ★☆☆ **1.9** Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo — 12
- ★☆☆ **4.1** Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas — 26
- ★☆☆ **5.10** Trombosis Venosa Profunda — 43
- ★☆☆ **3.4** Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks — 22
- ★☆☆ **5.4** Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva — 37

Practica: Libro Gordo Cardiología, preguntas 43–45, 70, 82.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 44
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.4 · 1.6 · 1.7 · 2.2 · 2.3 · 2.5 · 2.6 · 3.1 · 3.2 · 4.2 · 4.6 · 5.1 · 5.2 · 5.7
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Cardiología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 14 temas

19 2.6. Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal GES 18
19 5.1. Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación GES 34
19 5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES GES 35
16 2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES GES 17
16 3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos 19
15 1.4. Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo 7
13 3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos 20
13 4.6. Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación GES 32
12 5.7. Disección Aórtica Aguda 40
11 4.2. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular GES 27
10 2.2. Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía 14
9 1.6. Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White 9
7 1.7. Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica 10
7 2.3. Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria 15

★★ Prioridad media · 17 temas

6 4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis 33
5 1.8. Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos GES 11
5 3.5. Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven 23
5 3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis 24
5 5.5. Pericarditis Aguda 38
4 1.2. Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático 5
4 4.3. Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica GES 28
4 5.3. Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla GES 36
3 4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática 29
3 4.5. Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral GES 31
3 5.6. Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis 39
2 1.1. Lectura Sistemática del Electrocardiograma 4
2 2.1. Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar GES 13
2 2.4. SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel GES 16
2 3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón 21
2 5.8. Aneurisma de Aorta Abdominal 41
2 5.9. Tromboembolismo Pulmonar 42

★ Prioridad baja · 7 temas

1 1.3. ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro 6
1 1.5. Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K 8
1 1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo 12
1 4.1. Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas GES 26
1 5.10. Trombosis Venosa Profunda 43
0 3.4. Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks 22
0 5.4. Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva GES 37